

Flashcards ENARM -- Cirugia

86 patologías · 489 tarjetas · generado 2026-09-12 por La Mole. Frente = pregunta tipo ENARM; Reverso = respuesta + dato diferencial.

Absceso Anorrectal

Tarjeta 1 -- FRENTE: Varón de 40 años con dolor anal pulsátil de inicio súbito, fiebre y tumefacción perianal dolorosa. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

REVERSO: Drenaje y vaciamiento con legrado bajo anestesia local, de forma precoz al hacer el diagnóstico. Si no se drena oportunamente puede complicar con gangrena de Fournier.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuál es el estándar de oro diagnóstico del absceso anal?

REVERSO: Ultrasonido endoanal: defecto hipoeoico e identificación de la cripta afectada. La toma de muestra para cultivo no está indicada.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Localización más frecuente del absceso anorrectal.

REVERSO: Perianal (60%), seguida de la isquiorrectal (30%); interfinteriano 5%, supraelevador 4% y submucoso 1%. Diferencial: la fístula cursa con drenaje persistente, no con dolor pulsátil agudo.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Paciente diabético con absceso anal. ¿Está indicado el antibiótico?

REVERSO: No es sistemático; sólo se recomienda en inmunocomprometidos (diabetes mellitus, obesidad mórbida, VIH, quimioterapia). En niños menores de 2 años el manejo es conservador con antibióticos.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Complicación que se desarrolla en un tercio de los pacientes tras el drenaje de un absceso anal.

REVERSO: Fístula anal; la recurrencia del absceso (10%) debe hacer sospechar fístula y tratarse como tal.

Abscesos Hepaticos

Tarjeta 1 -- FRENTE: Varón de 60 años, diabético, con fiebre en espigas, escalofríos y dolor en hipocondrio derecho. Agente más frecuente del absceso hepático piógeno y lóbulo más afectado.

REVERSO: Escherichia coli (66% de los casos); el lóbulo derecho, por ser más grande y con mayor aporte de sangre portal. Diferencial: el amebiano es único, en varones jóvenes con antecedente de diarrea.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Estudio de primera línea y estudio de elección para el absceso piógeno hepático.

REVERSO: Ultrasonido (lesiones redondeadas hipoeoicas con ecos internos) de primera línea; la TC con contraste es el estudio de elección (imágenes hipodensas con realce periférico, con niveles hidroaéreos si generan gas).

Tarjeta 3 -- FRENTE: Esquema antibiótico empírico de elección del absceso hepático piógeno y su duración.

REVERSO: Cefalosporina de 3.ª generación (o posterior) + metronidazol, o piperacilina-tazobactam, por 4-6 semanas con cobertura para gramnegativos y anaerobios.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Absceso hepático piógeno único, unilocular, de 7 cm. ¿Qué drenaje está indicado?

REVERSO: Drenaje percutáneo con catéter (mayores de 5 cm), que se mantiene hasta que cese el drenaje (~7 días); los <5 cm pueden manejarse con aspiración con aguja. Diferencial: abscesos múltiples o multiloculados requieren valorar drenaje quirúrgico.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Varón de 30 años con antecedente de disentería, fiebre de 39 °C y hepatomegalia dolorosa; pus con aspecto de 'pasta de anchoas'. Diagnóstico y tratamiento de primera línea.

REVERSO: Absceso hepático amebiano (*Entamoeba histolytica*): metronidazol por 7-10 días (curación en 95% a 72-96 h) por vía oral; serología por hemaglutinación indirecta positiva en 92-97%. La punción percutánea se indica si >10 cm o sin mejoría a 72 h.

Tarjeta 6 -- FRENTE: En gammagrafía, ¿qué absceso hepático se ve 'frío' y cuál 'caliente'?

REVERSO: El amebiano se ve 'frío' con bordes brillantes; el piógeno se ve 'caliente' (con galio). Diferencial: el AHA habitualmente es único (80%), en el lóbulo derecho, con pus estéril.

Ametropias

Tarjeta 1 -- FRENTE: Niño que ve bien de cerca y mal de lejos; longitud axial del ojo mayor de 24.5 mm. Diagnóstico y tipo de lente.

REVERSO: Miopía: foco posterior por delante de la retina; se corrige con lente divergente (plano-cóncavo o bicóncavo). Diferencial: hipermetropía = ojo corto (<22 mm), afecta la visión cercana.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Adulto con cefalea frontal y visión borrosa de cerca que compensaba con esfuerzo hasta los 40 años. Diagnóstico.

REVERSO: Hipermetropía descompensada: el cristalino corrige funcionalmente los grados bajos hasta ~40 años, cuando pierde deformabilidad; se corrige con lente convergente o esférico.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Visión borrosa de cerca y de lejos con dificultad para los detalles finos, por diferencia de curvatura entre meridianos corneales. Diagnóstico.

REVERSO: Astigmatismo (variación anatómica, no patológica): el eje vertical es mayor que el horizontal; se corrige con lente esfero-cilíndrica, indicando el eje con precisión.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Adolescente con astigmatismo progresivo, adelgazamiento corneal en cono y anillo de Fleischer. Diagnóstico, estudio confirmatorio y primera línea.

REVERSO: Queratocono; el diagnóstico definitivo es topográfico (paquimetría central <500 µm). Primera línea: lentes aéreos, luego rígidos permeables al gas; trasplante corneal si progresa.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Criterios de seguridad de la GPC para ofrecer cirugía refractiva en un adulto.

REVERSO: Miopía ≤ -7 dioptrías, hipermetropía hasta +5 dioptrías y astigmatismo hasta -5 dioptrías, con visión estable ≥2 años. Contraindicada <21 años, en queratocono, diabetes, glaucoma o embarazo.

Anexos Oftalmología

Tarjeta 1 -- FRENTE: Paciente con artritis en tratamiento con hidroxicloroquina. ¿Qué efecto ocular se vigila?

REVERSO: Discromatopsia y defectos del campo visual (maculopatía pigmentaria con Plaquenil). Diferencial: la digoxina produce visión en color amarillo.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Efecto ocular característico del etambutol.

REVERSO: Neuritis óptica. Diferencial: la amiodarona produce espirales corneales y retinopatía pigmentaria.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Ojo rojo con dolor moderado, visión borrosa, inyección pericorneal, pupila pequeña y respuesta pupilar precaria a la luz. Diagnóstico.

REVERSO: Uveítis anterior aguda (iritis). Diferencial: conjuntivitis con descarga copiosa y pupila normal; glaucoma agudo con pupila moderadamente dilatada y fija, presión elevada y córnea empañada.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Ojo rojo con dolor severo, visión marcadamente borrosa, córnea empañada, pupila dilatada y fija. Diagnóstico.

REVERSO: Glaucoma agudo de ángulo cerrado. Diferencial: en la uveítis anterior la pupila es pequeña con presión intraocular normal.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Fármaco sistémico que produce glaucoma y catarata.

REVERSO: Corticosteroides. Diferencial: la isotretinoína produce xeroftalmia severa a largo plazo.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Visión borrosa en un paciente psiquiátrico en tratamiento con tioridazina.

REVERSO: Visión borrosa por tioridazina (también clorpromazina). Diferencial: los neurolépticos pueden producir nistagmo y la compazine crisis oculogíricas.

Blefaritis

Tarjeta 1 -- FRENTE: Mujer joven con inflamación palpebral crónica, cilindros de fibrina y ulceración fina en la base de las pestañas, con orzuelos. Tipo de blefaritis y agente infeccioso más común.

REVERSO: Blefaritis anterior estafilocócica; el *Staphylococcus aureus* es el agente infeccioso más común (y la rosácea, la dermatosis más asociada). Diferencial: la seborreica cursa con caspa grasa y sin orzuelo.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Adulto mayor con caspa grasa depositada en el margen palpebral, sin alteraciones de las pestañas ni orzuelo. Diagnóstico.

REVERSO: Blefaritis anterior seborreica. Diferencial: la estafilocócica se acompaña de ulceración, cicatrización y pérdida de pestañas.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Blefaritis posterior: estructura implicada y complicación frecuente.

REVERSO: Disfunción de las glándulas de Meibomio; se acompaña con frecuencia de chalazión múltiple (la blefaritis es factor de riesgo de chalazión).

Tarjeta 4 -- FRENTE: Tratamiento no farmacológico de la blefaritis y su duración mínima.

REVERSO: Aseo palpebral con compresas tibias, masaje del borde palpebral y retiro de collarettes, por al menos 6 semanas.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Cuándo se indica biopsia en un paciente con blefaritis?

REVERSO: Ante sospecha de carcinoma; el tiempo de ruptura de la película lagrimal sirve como marcador de respuesta terapéutica.

Cancer De Cabeza Y Cuello

Tarjeta 1 -- FRENTE: Principal factor de riesgo del carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello.

REVERSO: Tabaco y alcohol (75-85% de los casos); la infección por VPH está en aumento en la orofaringe (~30-35%). Diferencial: los tumores asociados a VPH son raros fuera de la orofaringe.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Ante un carcinoma epidermoide de orofaringe, ¿qué inmunohistoquímica es mandatoria y qué implica?

REVERSO: p16, marcador indirecto de VPH; los tumores VPH positivos tienen un pronóstico significativamente mejor.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Estudio de elección para el estadiaje sistémico del cáncer de cabeza y cuello.

REVERSO: Tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa (PET-FDG); alternativa: TC de tórax. El estadiaje local es TC/RM de cabeza y cuello con endoscopia rígida.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Estrategia de preservación de órgano en el cáncer laríngeo localmente avanzado.

REVERSO: Quimioterapia con cisplatino + radioterapia (concurrente o secuencial). En T1-T2 basta terapia unimodal (radioterapia o cirugía conservadora).

Tarjeta 5 -- FRENTE: Criterio para colocar nutrición enteral antes del tratamiento del cáncer de cabeza y cuello.

REVERSO: Desnutrición severa: pérdida mayor de 10% del peso en los últimos 6 meses (sonda nasogástrica; gastrostomía percutánea si el soporte será prolongado).

Tarjeta 6 -- FRENTE: Riesgo y ventana temporal de recurrencia en el cáncer de cabeza y cuello regionalmente avanzado.

REVERSO: 40-60%, la mayoría en los primeros 2 años de seguimiento; los segundos cánceres aparecen a razón de 2-4% por año (carcinogénesis en campo por tabaco).

Cancer Prostatico

Tarjeta 1 -- FRENTE: Varón de 48 años con padre con cáncer de próstata. ¿A partir de qué edad inicia el tamizaje y con qué pruebas?

REVERSO: A los 40 años (sin factores de riesgo, a los 50): tacto rectal y antígeno prostático específico (APE), el mejor marcador de actividad tumoral.

Tarjeta 2 -- FRENTE: APE de 4.2 ng/ml en dos mediciones consecutivas. Siguiendo paso según la GPC.

REVERSO: Repetir la prueba y medir la fracción libre; APE libre <25% = riesgo alto, se envía a biopsia. APE >5.5 ng/ml también indica biopsia. Diferencial: APE <2.5 ng/ml sólo se mide cada 2 años.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Estudio diagnóstico confirmatorio del cáncer prostático.

REVERSO: Biopsia prostática transrectal o transperineal guiada por ultrasonido. Diferencial: la TC evalúa extensión linfática (si APE >20 ng/dl) y el gammagrama óseo la extensión ósea en riesgo alto.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Estudio de elección para evaluar metástasis óseas en cáncer prostático y cuándo solicitarse.

REVERSO: Gammagrama óseo, sólo en pacientes de riesgo alto (la TC se reserva para extensión linfática o APE >20 ng/dl).

Tarjeta 5 -- FRENTE: Zona prostática de la que se origina el carcinoma y sitio de metástasis ósea típico.

REVERSO: Zona periférica de la próstata; metástasis vertebrales con fracturas patológicas. Diferencial: la HPB crece de forma simétrica y no es lesión premaligna.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Cáncer prostático localizado de riesgo bajo. ¿Qué modalidades admite la GPC?

REVERSO: Vigilancia activa (APE seriado + biopsias periódicas), braquiterapia, prostatectomía radical o radioterapia externa. Diferencial: en riesgo alto se usa deprivación androgénica + radioterapia radical.

Cancer Testicular

Tarjeta 1 -- FRENTE: Hombre de 26 años con masa testicular sólida e indolora. ¿Qué indica el hallazgo y cuál es el estudio inicial?

REVERSO: La masa testicular sólida e indolora es patognomónica de tumor testicular; inicia con ultrasonido testicular con transductor de alta frecuencia (sensibilidad >90%).

Tarjeta 2 -- FRENTE: Marcadores tumorales del cáncer testicular y su medición con valor pronóstico.

REVERSO: α -fetoproteína, β -hCG y deshidrogenasa láctica; los niveles con valor de estadiaje y pronóstico son los medidos 2 semanas después de la orquiectomía, no los de presentación.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Qué tumor germinal no seminomatoso secreta β -hCG y cuál secreta α -fetoproteína?

REVERSO: Coriocarcinoma: β -hCG, muy agresivo, pequeño, con hemorragia y necrosis; tumor del saco vitelino: α -fetoproteína (cuerpos de Schiller-Duval, en lactantes). Diferencial: el seminoma puro nunca produce α -fetoproteína.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Tratamiento quirúrgico definitivo del tumor testicular y vía prohibida.

REVERSO: Orquiectomía inguinal radical (único medio aceptable para diagnóstico y estadiaje); la vía escrotal está prohibida porque altera el drenaje linfático y disemina células malignas.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Quimioterapia de elección de los tumores germinales testiculares.

REVERSO: Bleomicina, etopósido y cisplatino; la bleomicina puede omitirse ante daño pulmonar o en deportistas de alto rendimiento.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Principal factor de riesgo de cáncer testicular y medida de detección temprana recomendada.

REVERSO: Criptorquidia (presente en 10% de los tumores); la GPC recomienda autoexploración testicular mensual entre los 15-30 años. Diferencial: el linfoma es la neoplasia testicular más común después de los 50 años.

Carcinoma De Celulas Renales

Tarjeta 1 -- FRENTE: Varón de 65 años con masa renal detectada incidentalmente. Subtipo histológico más común y su peso en las metástasis.

REVERSO: Carcinoma de células claras (75% de los tumores, 90% de las metástasis). Diferencial: papilar (10-15%) y cromóforo (5%) son más indolentes; el oncocitoma es benigno.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Tríada clínica clásica del carcinoma de células renales y su frecuencia.

REVERSO: Hematuria, dolor en fosa renal y masa abdominal palpable, presente sólo en 6-10% de los casos; la mayoría se presenta asintomático.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Síndrome paraneoplásico más frecuente del carcinoma de células renales.

REVERSO: Síndrome anémico (88% de los casos); también hipercalcemia, poliglobulia, fiebre y velocidad de sedimentación elevada.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Estudio de elección para el estadiaje del carcinoma de células renales.

REVERSO: Tomografía computada (o resonancia magnética) con contraste intravenoso de tórax, abdomen y pelvis; la confirmación es histopatológica.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Tratamiento estándar del carcinoma de células renales no metastásico.

REVERSO: Nefrectomía parcial o radical según la localización y la posibilidad de cirugía conservadora de nefronas; la enfermedad es resistente a radioterapia y quimioterapia tradicionales.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Forma familiar asociada al carcinoma de células renales.

REVERSO: Síndrome de Von Hippel-Lindau. Otros factores de riesgo: tabaquismo, obesidad y exposición a tricloroetileno o cadmio.

Carcinoma De Celulas Transicionales

Tarjeta 1 -- FRENTE: Varón de 65 años con hematuria macroscópica indolora y disuria. Sospecha principal y factor de riesgo más importante.

REVERSO: Carcinoma urotelial (células transicionales) de vejiga; el tabaco es el principal factor de riesgo (triplica el riesgo), con latencia de ~20 años. Diferencial: Schistosoma haematobium se asocia a tumores escamosos.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Manifestación clínica inicial del cáncer de vejiga en 80-90% de los casos.

REVERSO: Hematuria, macro o microscópica, que puede acompañarse de disuria, polaquiuria y urgencia urinaria.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Estudio inicial y estándar de oro diagnóstico del cáncer urotelial.

REVERSO: Ultrasonido abdominal como estudio inicial (evita contraste); el estándar de oro es la cistoscopia con biopsia y resección transuretral. La citología urinaria tiene sensibilidad de 90%.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Citología urinaria positiva sin tumor visible en la vejiga. ¿Siguiendo paso?

REVERSO: Cateterización retrógrada de los uréteres hasta las pelvis renales para identificar tumores de la vía urinaria proximal.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Tratamiento estándar del tumor vesical superficial (no invasor de músculo).

REVERSO: Resección transuretral + inmunoterapia intravesical con BCG (y mitomicina C), por las altas recurrencias (60-70%). Diferencial: el tumor que invade muscular propia exige quimioterapia neoadyuvante con platinos + cistectomía radical.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Supervivencia a 5 años del cáncer vesical según invasión muscular.

REVERSO: 95% no invasor de muscular, 50% invasor y 6% metastásico.

Catarata

Tarjeta 1 -- FRENTE: Principal causa de ceguera reversible a nivel mundial.

REVERSO: Catarata senil; el diagnóstico es la observación directa del cristalino con oftalmoscopio (desde los 40 años con factores de riesgo y los 50 en población general).

Tarjeta 2 -- FRENTE: Tratamiento quirúrgico de la catarata y su indicación.

REVERSO: Facoemulsificación con colocación de lente intraocular, indicada cuando la pérdida visual atribuible a la opacificación del cristalino interfiere con las actividades diarias y no mejora con graduación óptica.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Medicación que, en uso crónico, es factor de riesgo de catarata.

REVERSO: Esteroides sistémicos o inhalados; también clorpromazina, fenotiazinas, tiazidas y antagonistas de canales de calcio >5 años. Otros factores: DM, tabaquismo, alcoholismo, radiación UV.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Manejo posquirúrgico de la cirugía de catarata.

REVERSO: Quinolona oftálmica más AINE tópico (u oral); los antibióticos sistémicos no están indicados.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Midriático contraindicado en paciente hipertenso para la exploración de cristalino.

REVERSO: Fenilefrina; se usa tropicamida como alternativa aceptada.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Pérdida de visión progresiva 2 años después de facoemulsificación con lente plegable endosacular. Diagnóstico más probable.

REVERSO: Opacificación de la cápsula posterior (hallazgo típico tardío de la cirugía de catarata; la endoftalmitis cursa con dolor e inflamación en las primeras 6 semanas).

Celulitis Preseptal Y Orbitaria

Tarjeta 1 -- FRENTE: Niño con edema e hiperemia palpebral, quemosis y movimientos oculares conservados. Diagnóstico y tratamiento.

REVERSO: Celulitis preseptal: inflamación anterior al septo orbitario; amoxicilina-clavulanato 500 mg cada 8 horas por 10 días por vía oral.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Signos que indican extensión posterior al septo orbitario.

REVERSO: Proptosis (exoftalmos) y oftalmoplejía (movimientos oculares restringidos); definen la celulitis orbitaria.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Complicaciones de la celulitis orbitaria.

REVERSO: Neuritis óptica séptica, diseminación intracraneal y trombosis del seno cavernoso; requiere antibioticoterapia parenteral y drenaje quirúrgico si hay absceso paraorbitario. Diferencial: la preseptal nunca restringe los movimientos oculares.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Qué estructura anatómica separa los tejidos blandos del párpado de los de la órbita?

REVERSO: El septo orbitario; los tejidos orbitarios son más susceptibles al daño inflamatorio que los preseptales.

Chalazion

Tarjeta 1 -- FRENTE: Nódulo duro de 2-8 mm en el tarso, bien definido, inmóvil y poco doloroso, de crecimiento crónico. Diagnóstico.

REVERSO: Chalazión: inflamación granulomatosa crónica de las glándulas de Meibomio con retención de secreción. Diferencial: el orzuelo es agudo, doloroso y con signos inflamatorios.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Chalazión mayor de 6 mm o refractario al manejo conservador. Tratamiento de elección.

REVERSO: Incisión y curetaje de forma ambulatoria.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Chalazión menor de 4 mm. Manejo farmacológico.

REVERSO: Triamcinolona intralesional 0.2 ml/5-10 mg; para lesiones de 4-6 mm, 0.2 ml/20-40 mg.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Padecimiento palpebral que actúa como factor de riesgo para desarrollar chalazión.

REVERSO: La blefaritis (especialmente la posterior por disfunción de Meibomio, donde el chalazión puede ser frecuente y múltiple).

Tarjeta 5 -- FRENTE: Síntoma visual que puede producir un chalazión.

REVERSO: Visión borrosa por astigmatismo inducido; la eversión palpebral puede mostrar un granuloma conjuntival.

Conjuntivitis

Tarjeta 1 -- FRENTE: Ojo rojo bilateral, prurito intenso y secreción mucosa acuosa, con rinitis estacional. Diagnóstico y primera línea.

REVERSO: Conjuntivitis alérgica (hipersensibilidad tipo I, polen como causa más frecuente): compresas frías, lubricantes, antihistamínico tópico (olopatadina) u oral (loratadina) y estabilizadores de mastocitos (cromoglicato de sodio).

Tarjeta 2 -- FRENTE: Légañas matutinas que impiden abrir los párpados, secreción mucopurulenta bilateral. Agente más frecuente y tratamiento de elección.

REVERSO: Conjuntivitis bacteriana aguda: Staphylococcus aureus (el más frecuente), S. pneumoniae en niños y H. influenzae en menores de 5 años; cloranfenicol oftálmico cada 6 horas por 7 días.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cuándo se indica cultivo en conjuntivitis?

REVERSO: En purulentas severas, crónicas o recurrentes que no responden al tratamiento, en cualquier grupo de edad.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Paciente con lentes de contacto que desarrolla conjuntivitis mecánica irritativa. Medida principal.

REVERSO: Suspender los lentes de contacto por al menos 2 semanas; manejo con hipromelosa y compresas frías.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Cuándo se aceptan esteroides tópicos en conjuntivitis alérgica?

REVERSO: No son de primera elección; sólo en inflamación grave y por periodos cortos (máximo 4 días).

Diferencial: la ciclosporina tópica es adyuvante en conjuntivitis atópica o vérica.

Cuidado Y Cicatrizacion De Las Heridas

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Cuándo alcanza su máxima producción la síntesis de colágeno en una herida y cuándo cesa el depósito?

REVERSO: La producción alcanza el máximo a las 2 semanas y el depósito se detiene alrededor de la 4.^a semana. Diferencial: la remodelación continúa hasta 6 meses.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Etapa de la cicatrización que inicia a las pocas horas del traumatismo.

REVERSO: Epitelización: las células epiteliales basales migran como monocapa bajo el coágulo hasta contactar el lado opuesto de la herida.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cuándo alcanza la herida su máxima fuerza tensora y qué proporción de la piel normal logra?

REVERSO: A las 4 semanas, y nunca supera el 80% de la fuerza tensora de la piel normal; depende del colágeno depositado y sus uniones cruzadas.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Qué células producen la contracción de la herida y en qué fase?

REVERSO: Miofibroblastos (fibroblastos diferenciados) en la segunda semana, con contracción centrípeta que reduce el defecto.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Duración de la remodelación del colágeno y sus eventos.

REVERSO: Inicia en la tercera semana y dura hasta 6 meses: el colágeno madura, se orienta, forma uniones cruzadas y gana resistencia, con disminución de la vasculatura neoformada.

Degeneracion Macular Relacionada Con La Edad

Tarjeta 1 -- FRENTE: Adulto mayor con metamorfopsia y líneas rectas onduladas en la cartilla de Amsler. Diagnóstico y hallazgo más temprano al fondo de ojo.

REVERSO: Degeneración macular relacionada con la edad; el signo más temprano son las drusas (variación en la densidad del pigmento del epitelio retiniano macular). Diferencial: la retina periférica no se involucra, por eso caminan sin problema pero no reconocen caras.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Forma más frecuente de degeneración macular y forma con pérdida visual más severa.

REVERSO: La seca o geográfica (90%, drusas y atrofia del epitelio pigmentario) es la más común; la húmeda o neovascular (10%, neovascularización coroidea) causa la pérdida visual más severa.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Tratamiento de primera línea de la degeneración macular húmeda.

REVERSO: Ranibizumab (inhibidor anti-VEGF) de primera intención, iniciado tan pronto como sea posible y en un máximo de 2 semanas tras el diagnóstico; alternativas: terapia fotodinámica y fotocoagulación.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Factor de riesgo más importante de la degeneración macular relacionada con la edad.

REVERSO: La edad (sexta-novena décadas); el tabaquismo, alcoholismo y exposición al sol aceleran el proceso, y la cirugía de catarata se asocia a su progresión.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Proteína que se acumula entre el epitelio pigmentario y la membrana de Bruch formando drusas.

REVERSO: Lipofusina; las drusas suaves miden ~30 µm y anteceden por décadas la alteración visual subjetiva (AMD seca).

Tarjeta 6 -- FRENTE: Escrutinio oftalmológico de un individuo asintomático de 70 años sin factores de riesgo.

REVERSO: Cada 2 años (19-40: cada 10; 41-55: cada 5; 56-65: cada 3; >65: cada 2). En riesgo alto (diabetes, catarata, glaucoma): >60 años cada año.

Desprendimiento Retiniano

Tarjeta 1 -- FRENTE: Fotopsias, moscas flotantes y sombra como 'cortina' que avanza, indolora. Diagnóstico y estudio de confirmación.

REVERSO: Desprendimiento retiniano regmatógeno; se confirma con oftalmoscopia indirecta (bolsa móvil blanquecina con desgarro) y, si no es posible, ultrasonido en modo B.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Tipo de desprendimiento retiniano más frecuente y su mecanismo.

REVERSO: Regmatógeno: desgarro o ruptura retiniana con acumulación de líquido subretiniano. Diferencial: el no regmatógeno se debe a tracción (retinopatía diabética proliferativa) o exudación (hipertensión maligna, eclampsia).

Tarjeta 3 -- FRENTE: Diabético con retinopatía proliferativa que desarrolla desprendimiento retiniano. Tipo y mecanismo.

REVERSO: No regmatógeno por tracción vitreoretiniana; sin fotopsias (no hay tracción desgarro) y el área desprendida es convexa con líquido móvil dependiente de la posición.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Pérdida visual en un paciente con lupus, sarcoidosis o enfermedad de Vogt-Koyanagi-Harada, retina convexa sin desgarros. Tratamiento de primera línea.

REVERSO: Desprendimiento seroso exudativo: prednisona en dosis decrecientes hasta 3 meses; ante falla, ciclosporina o azatioprina. Diferencial: el regmatógeno requiere cirugía urgente.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Desprendimiento regmatógeno sin involucro macular. Conducta.

REVERSO: Tratamiento urgente (vitrectomía o cerclaje escleral); puede programarse si hay involucro macular o evolución mayor de 10 días. Los pequeños periféricos pueden tratarse con fotocoagulación láser profiláctica.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Factores de riesgo clásicos del desprendimiento retiniano regmatógeno.

REVERSO: Miopía, cirugía ocular previa (catarata/lente intraocular), trauma ocular, desgarro retiniano y desprendimiento vítreo posterior.

Disecccion Aortica

Tarjeta 1 -- FRENTE: Dolor torácico súbito 'en desgarro' que migra a la espalda, con pulso ausente en un miembro y diferencia de presión sistólica de 20 mm Hg. Diagnóstico sospechado y estudio de elección.

REVERSO: Disección aórtica; la TC (helicoidal multicorte: sensibilidad 100%, especificidad 99%) es el estudio más utilizado; también USG transesofágico con 'flap' íntimo-medial y signo del pico.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Tipo Stanford que requiere cirugía urgente.

REVERSO: Tipo A (compromete la aorta ascendente), por el riesgo de taponamiento cardíaco, regurgitación aórtica e IAM. Diferencial: la tipo B (descendente) se trata inicialmente de forma médica.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Tratamiento médico inicial de la disección aórtica y metas de control.

REVERSO: Betabloqueadores IV (labetalol, esmolol) para controlar FC y presión: FC <60 lpm y PAS de 100-120 mm Hg; los vasodilatadores nunca antes de controlar la FC (taquicardia refleja que extiende la disección).

Tarjeta 4 -- FRENTE: Paciente asmático con disección aórtica: ¿qué betabloqueador se prefiere?

REVERSO: Esmolol, por su vida media extremadamente corta (mejor opción si hay contraindicación a betabloqueadores no cardioselectivos como asma, ICC aguda o EPOC).

Tarjeta 5 -- FRENTE: Mortalidad de la disección aórtica sin tratamiento a las 24 horas.

REVERSO: 50% (23% a las 6 horas, 75% a 2 semanas y 90% a 3 meses); hipertensión arterial presente en 70-80% de los casos.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Indicaciones de cirugía urgente en disección tipo B tratada médicamente.

REVERSO: Fracaso del tratamiento médico (dolor persistente), afección del SNC, insuficiencia renal, progresión de la disección, isquemia de órganos abdominales, medular o de extremidades y descontrol hipertensivo. Complicación temida de la reparación: paraplejía (2-6%).

Dolor Abdominal Agudo

Tarjeta 1 -- FRENTE: Dolor periumbilical que migra a fosa ilíaca derecha en menos de 24 horas, anorexia, leucocitosis 12,000 y neutrofilia 80%. Diagnóstico y escala.

REVERSO: Apendicitis aguda; valoración con escala de Alvarado (MANTRELS): 7-8 probable y 9-10 apendicitis, ambos con revisión quirúrgica.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Tratamiento de elección de la apendicitis aguda y profilaxis antibiótica preoperatoria.

REVERSO: Apendicectomía laparoscópica; profilaxis con cefoxitina 2 g IV. Diferencial: la complicación temprana más frecuente es la infección de la herida y la tardía, el absceso residual.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Mujer en edad reproductiva con amenorrea, dolor abdominal y sangrado transvaginal; útero vacío al ultrasonido y β -hCG >1,500 mUI/ml. Diagnóstico y conducta.

REVERSO: Embarazo ectópico roto: evaluación ginecológica inmediata y tratamiento quirúrgico (laparoscopia o laparotomía). Si es estable y sin ruptura (saco <40 mm, β -hCG 6,000-15,000 mUI/L) puede usarse metotrexato.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Dolor abdominal, masa pulsátil e hipotensión súbita en un varón de 70 años. Diagnóstico y estudio de tamizaje del padecimiento base.

REVERSO: Ruptura de aneurisma aórtico abdominal (diámetro ≥ 3 cm; reparación electiva si >5.5 cm): evaluación quirúrgica urgente. El ultrasonido abdominal en tiempo real es el estudio de elección para tamizaje y seguimiento.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Paciente con cirugía abdominal previa, distensión, vómito y ruidos metálicos. Causa más frecuente y primer paso terapéutico.

REVERSO: Obstrucción intestinal por adherencias (65-75%); descompresión con sonda nasogástrica por 48-72 horas (efectiva hasta 90%) con ayuno y reposición hídrica. La TC con contraste es el estándar de oro.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Abdomen agudo con aire libre subdiafragmático en radiografía de tórax en bipedestación. Diagnóstico y manejo de elección.

REVERSO: Perforación intestinal (p. ej. úlcera péptica perforada): cirugía urgente, con abordaje laparoscópico como manejo de elección. La TC simple y con contraste hidrosoluble es el estudio de elección.

Endoftalmitis

Tarjeta 1 -- FRENTE: Dolor ocular sordo y pérdida aguda de visión con hipopión, 2 semanas después de una facoemulsificación. Diagnóstico.

REVERSO: Endoftalmitis posquirúrgica (la mayoría ocurre en las primeras 6 semanas); inflamación intraocular extensa con células en cámara anterior, hipopión y vitritis. Diferencial: la opacificación capsular es indolora y progresiva.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Estudio que confirma el diagnóstico de endoftalmitis.

REVERSO: Tinción de Gram y cultivo del líquido de la cámara anterior o del vitreo; las células se observan por biomicroscopía con lámpara de hendidura.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Tratamiento empírico intravítreo de la endoftalmitis.

REVERSO: Vancomicina + ceftazidima intravítreas; continuar con dosis tópicas. En casos graves, vitrectomía para remover detritus.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Profilaxis antibiótica de la cirugía de catarata.

REVERSO: Moxifloxacino tópico 2 horas antes de la cirugía y cada 15 minutos en la primera hora; cefuroxima intracameral al finalizar.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Microorganismos de virulencia baja que producen endoftalmitis de evolución indolente.

REVERSO: Propionibacterium acnés y Staphylococcus epidermidis; los gramnegativos suelen asociarse a un curso rápidamente destructivo.

Enfermedad Arterial Periferica

Tarjeta 1 -- FRENTE: Dolor en pantorrilla al caminar menos de 500 metros que cede con el reposo, pulsos distales disminuidos. Diagnóstico y estudio de primera línea.

REVERSO: Enfermedad arterial periférica (claudicación intermitente, Fontaine II); examen no invasivo de primera línea: índice tobillo-brazo (ITB) <0.9 en reposo.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ITB de 1.0 con síntomas típicos de claudicación. ¿Siguiendo estudio?

REVERSO: ITB con ejercicio: una disminución del 15% después del ejercicio confirma el diagnóstico. Diferencial: ITB >1.40 (no compresible) obliga a medir el índice dedo-brazo.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Fármaco de primera elección para la claudicación intermitente, con dosis.

REVERSO: Cilostazol, 100 mg cada 12 horas por 3 meses; la pentoxifilina no es un tratamiento efectivo para claudicación.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Clasificación que define dolor isquémico en reposo y úlcera o gangrena.

REVERSO: Fontaine: estadio III dolor isquémico en reposo, estadio IV úlcera o gangrena (Rutherford: grado II categoría 4 y grado III categorías 5-6).

Tarjeta 5 -- FRENTE: Medidas de higiene arterial para un paciente con claudicación.

REVERSO: Suspensión del tabaco, ejercicio supervisado, evitar ropa ajustada y calor local, no elevar las extremidades, calzado especial; control de HbA1c <7% en diabéticos. Diferencial: la revascularización se

reserva para claudicación limitante refractaria.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Isquemia aguda de miembro inferior en un paciente con fibrilación auricular. Manejo inicial.

REVERSO: Anticoagulación sistémica con heparina (si no está contraindicada), además de evaluar revascularización; las lesiones cortas y no calcificadas son candidatas a tratamiento endovascular.

Enfermedad De Legg Calve Perthes

Tarjeta 1 -- FRENTE: Niño de 6 años con claudicación insidiosa, limitación de abducción y rotación interna de cadera, dolor irradiado a la cara interna del muslo. Diagnóstico.

REVERSO: Enfermedad de Legg-Calvé-Perthes: necrosis isquémica (aséptica) de la cabeza femoral; pico a los 4-8 años, unilateral en 90%, predomina en varones.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Estudio inicial ante sospecha de Legg-Calvé-Perthes y hallazgo de fractura subcondral.

REVERSO: Radiografías AP y lateral de cadera en posición de Lowenstein ('rana'); la fractura subcondral se ve como el 'signo de la uñetada de Waldenström'. Diferencial: la gammagrafía con Tc-99 muestra la hipocaptación antes que la radiografía.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Sistema radiológico de extensión de la osteonecrosis con peor pronóstico.

REVERSO: Herring: el colapso mayor de 50% de la altura del pilar lateral (grupo C) tiene mal pronóstico; grupo A (pilar lateral normal) tiene buen pronóstico.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Objetivo inicial del tratamiento conservador de la Perthes.

REVERSO: Recuperar la movilidad completa de la cadera con reposo, evitar la carga y mantener la abducción (cabestrillo, muletas, yeso de Petrie en abducción); después, observación (grado A o <6 años) o procedimientos de contención (osteotomías femorales o pélvicas).

Tarjeta 5 -- FRENTE: Edad de máxima incidencia de la Legg-Calvé-Perthes y lado más afectado.

REVERSO: 4-8 años (rango 2-13); afecta más a varones y es unilateral en 90% de los casos.

Enfermedad Diverticular Del Colon

Tarjeta 1 -- FRENTE: Mujer de 62 años con dolor en fosa ilíaca izquierda, náusea y leucocitosis; PCR >50 mg/L. Diagnóstico y estudio de elección.

REVERSO: Diverticulitis aguda; la tomografía computarizada es el estándar de oro (todo cuadro se documenta con TC), valorada con la escala de Hinchey modificada por Kaiser.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Sitio de localización de los divertículos del colon y tipo histológico.

REVERSO: Colon sigmoideas (95%); son pseudodivertículos o falsos (mucosa y submucosa sin capa muscular), por pulsión en zonas de debilidad donde perforan las arterias colónicas.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Diverticulitis con absceso pélvico de 7 cm. Manejo.

REVERSO: Hinchey II: drenaje percutáneo (los abscesos >5 cm); los <5 cm se manejan con antibióticos. Diferencial: Hinchey III-IV (peritonitis purulenta o fecal) exige cirugía de urgencia con resección de sigmoideas, anastomosis primaria e ileostomía derivativa en asa.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Manejo ambulatorio de la diverticulitis no complicada.

REVERSO: Dieta de líquidos claros ± antibióticos orales (no son de rutina) si el paciente tolera vía oral y tiene seguimiento; si no mejoría: ayuno con metronidazol + ciprofloxacino o ceftriaxona IV por 7-10 días.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Cuándo se realiza la colonoscopia en un paciente con diverticulitis aguda?

REVERSO: No está indicada en el episodio agudo; se realiza 6 semanas después para descartar neoplasia. La única indicación aguda es la hemorragia digestiva baja (método de elección y terapéutico).

Tarjeta 6 -- FRENTE: Factor de riesgo farmacológico para sangrado diverticular.

REVERSO: Aspirina y AINE (riesgo alto y persistente de sangrado diverticular); la dieta alta en fibra protege contra la enfermedad diverticular.

Enfermedad Hemorroidal

Tarjeta 1 -- FRENTE: Sangrado rojo brillante que mancha el papel higiénico sin dolor, con prolapso que se reduce espontáneamente al cesar el pujo. Grado y tratamiento.

REVERSO: Hemorroides internas grado II (por encima de la línea pectínea, sin inervación sensitiva): tratamiento conservador (fibra, agua, flavonoides, baños de asiento) y, en algunos casos, ligadura con banda elástica o esclerosis.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Tratamiento de elección de las hemorroides internas grado I-III refractarias al manejo médico.

REVERSO: Ligadura con banda elástica (efectividad 70%), colocada por encima de la línea ano-cutánea. Diferencial: el grado IV exige hemorroidectomía.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Indicaciones de hemorroidectomía.

REVERSO: Fracaso del tratamiento médico, recurrencia tras ligadura, hemorroides externas, hemorroide trombosada y hemorroides internas grados III y IV; la técnica cerrada de Ferguson es la preferida.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Tumefacción anal azulada, firme y muy dolorosa, de inicio abrupto, sin relación con la defecación. Diagnóstico y conducta.

REVERSO: Trombosis hemorroidal externa: la escisión quirúrgica del trombo se indica dentro de las primeras 72 horas del inicio (urgencia proctológica); si es indolora o hay edema, manejo médico con baños de asiento, analgésicos y ablandadores.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Complicación postoperatoria más frecuente de la hemorroidectomía.

REVERSO: Retención aguda de orina, principalmente al colocar suturas en el anodermo.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Hemorroides internas grado IV con prolapso irreducible, trombosis múltiples y edema severo tras un parto. Diagnóstico y manejo.

REVERSO: Fluxión hemorroidal: tratamiento intrahospitalario (reposo, calor local húmedo, analgésicos, ablandador de heces); la cirugía no siempre es la mejor opción por el edema. Diferencial: el método de Lord (dilatación forzada del esfínter interno) puede remitir el prolapso.

Epifisiolisis Femoral Proximal

Tarjeta 1 -- FRENTE: Adolescente obeso de 13 años con dolor en rodilla e inguinal, cadera en rotación externa y marcha claudicante. Diagnóstico y factor de riesgo principal.

REVERSO: Epifisiolisis femoral proximal: desplazamiento de la epífisis sobre la metáfisis; la obesidad es el principal factor de riesgo (60% por encima del percentil 90).

Tarjeta 2 -- FRENTE: Estudio confirmatorio de la epifisiolisis y signos radiográficos.

REVERSO: Radiografías AP de pelvis y Lowenstein: ensanchamiento e irregularidad de la fisis, deslizamiento, línea de Klein, signo de Trethowan y blancura de Steel; el signo de Drennan es clínico (rotación externa al flexionar la cadera).

Tarjeta 3 -- FRENTE: Clasificación por grados del desplazamiento en la epifisiolistesis femoral proximal.

REVERSO: Grado I: 0-30%, grado II: 31-60% y grado III: >60%; por el ángulo de Southwick: leve <30°, moderado 31-60° y severo ≥60°.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Tratamiento de elección de la epifisiolistesis femoral proximal.

REVERSO: Fijación in situ quirúrgica con tornillo canulado, preferentemente fijando ambas caderas (el deslizamiento contralateral ocurre en 60% de los casos, en promedio a los 18 meses).

Tarjeta 5 -- FRENTE: Complicación principal de la epifisiolistesis si el tratamiento se retrasa.

REVERSO: Osteonecrosis avascular de la cabeza femoral; por ello debe referirse al ortopedista pediatra tan pronto se sospeche.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Forma de presentación más frecuente en la epifisiolistesis: aguda o crónica, y cómo se define.

REVERSO: Crónica (>3 semanas de evolución) con dolor en rodilla irradiado al muslo, progresivo, que cede con reposo; la aguda (<3 semanas) cursa con dolor inguinal intenso que incapacita el apoyo.

Epistaxis

Tarjeta 1 -- FRENTE: Niño con epistaxis autolimitada tras rascarse la nariz. Sitio más frecuente del sangrado.

REVERSO: Región anterior: área de Little (plexo de Kiesselbach). Diferencial: en adultos mayores predomina el sangrado posterior, que a menudo requiere taponamiento.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Epistaxis grave posterior que no cede con presión local ni vasoconstrictor. Medida de primera línea siguiente.

REVERSO: Taponamiento nasal anterior por 1-5 días (gasas lubricadas, material expansible o sondas inflables); si persiste, procedimientos quirúrgicos como ligadura de la arteria esfenopalatina o cauterización endoscópica.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Manejo inicial de la epistaxis leve en un paciente no hipertenso.

REVERSO: Presión local sobre las alas nasales + vasoconstrictor local (oximetazolina, fenilefrina o nafazolina); si no responde, cauterización eléctrica o con nitrato de plata.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Causa más frecuente de epistaxis y causa sistémica más común.

REVERSO: Traumática digital/autoinducida; la púrpura trombocitopénica inmune es la causa sistémica más común. En adolescentes varones con obstrucción nasal unilateral: angiofibroma.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Epistaxis recurrente con sospecha de neoplasia nasal. ¿Qué se solicita?

REVERSO: Exploración endoscópica por especialista y tomografía computarizada de nariz y senos paranasales; los casos que requieren embolización se refieren a tercer nivel.

Escoliosis

Tarjeta 1 -- FRENTE: Adolescente con desnivel de hombros al flexionar la columna (prueba de Adams positiva) y asimetría del tronco. Diagnóstico y etiología más común.

REVERSO: Escoliosis estructurada: rotación vertebral + incurvación; la etiología más común es la idiopática (diagnóstico de exclusión). Diferencial: la actitud escoliótica desaparece en decúbito supino y no tiene rotación.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuándo se indica radiografía de columna en un escolar con sospecha de escoliosis?

REVERSO: Radiografía posteroanterior cuando el ángulo de rotación del tronco (prueba de Adams) es mayor de 5°; la proyección lateral, si hay dolor o mala alineación en el plano lateral.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Dirección típica de la curva torácica y de la lumbar en la escoliosis idiopática.

REVERSO: Torácica (T2-T11) convexa hacia la derecha; toracolumbar y lumbar suelen ser convexas hacia la izquierda.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Tratamiento que detiene la progresión de la escoliosis sin modificar la curva inicial, y tipos de corsé.

REVERSO: El corsé: Milwaukee para curvas altas, Boston para curvas bajas. La cirugía (instrumentación ± artrodesis) reduce la magnitud de la curva.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Complicación cardiorrespiratoria tardía de la escoliosis no tratada.

REVERSO: Insuficiencia respiratoria, sobrecarga de las cámaras derechas y corazón pulmonar por alteración del desarrollo de la caja torácica. La escoliosis no genera dolor.

Esguince Cervical

Tarjeta 1 -- FRENTE: Mujer de 30 años tras choque por alcance con dolor cervical, espasmo paraespinal y sin déficit neurológico. Diagnóstico y clasificación.

REVERSO: Esguince cervical grado II (Québec Task Force: rigidez y dolor localizado, sin signos neurológicos); grado I = sólo dolor y espasmo; grado III = signos neurológicos; grado IV = lesión ósea.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Qué regla determina la indicación de radiografías cervicales tras un accidente?

REVERSO: The Canadian C-Spine Rule: aplica en pacientes estables y alertas (Glasgow 15); indicaciones: edad >65 años, parestesias en extremidades o mecanismos peligrosos (caída ≥90 cm, trauma axial, choque >100 km/h).

Tarjeta 3 -- FRENTE: Analgesia recomendada por la GPC para el esguince cervical.

REVERSO: Combinaciones naproxeno-paracetamol, piroxicam-paracetamol o diclofenaco-paracetamol, con IBP concomitante si hay enfermedad péptica. Se evita el collarín en grados I y II.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Manejo no farmacológico del esguince cervical en las primeras 72 horas y después.

REVERSO: Primeras 72 horas: información, frío local y recomendaciones posturales; después: calor superficial, ejercicios cervicales activos y aumento progresivo de la actividad. Se evita reposo absoluto y esteroides.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Raíz cervical con debilidad de extensores de la muñeca y disminución del reflejo bicipital.

REVERSO: C6 (debilidad de extensores de la muñeca e hipoestesia del antebrazo y dedos primero y tercero). Diferencial: C7 = reflejo tricipital disminuido; C5 = deltoides y reflejo bicipital.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Indicación quirúrgica del esguince cervical.

REVERSO: Grado III con dolor persistente refractario al manejo conservador y grado IV (fractura/luxación) para estabilizar la columna cervical.

Esguince De Tobillo

Tarjeta 1 -- FRENTE: Mecanismo de lesión más común del esguince de tobillo.

REVERSO: Supinación con aducción e inversión del pie en flexión plantar; cursa con dolor, limitación funcional, edema y equimosis.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Qué criterios indican radiografía de tobillo tras un esguince?

REVERSO: Criterios de Ottawa (sensibilidad casi 100%): dolor maleolar + sensibilidad ósea en el borde posterior o punta de los maléolos (6 cm distales) o incapacidad para soportar peso por 4 pasos.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Tobillo con edema severo que se extiende más de 4 cm por la superficie peronea, equimosis severa e incapacidad para caminar. Grado y manejo.

REVERSO: Esguince grado III (ruptura completa del ligamento con inestabilidad mecánica): evaluación para manejo quirúrgico y referencia al segundo nivel. Diferencial: grado IV = luxación articular.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Manejo del esguince de tobillo en las primeras 72 horas.

REVERSO: Sin apoyo las primeras 48 horas, hielo local cada 8 horas por 20 minutos, elevación a 30° con ejercicios a tolerancia y vendaje elástico no compresivo (tipo Jones si el edema es bimaléolar o progresivo).

Tarjeta 5 -- FRENTE: Analgesia de elección del esguince de tobillo en el adulto mayor.

REVERSO: Paracetamol, minimizando los AINE por sus efectos adversos; en riesgo de sangrado digestivo puede usarse un inhibidor de COX-2.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Esguince grado I con dolor maleolar pero sin sensibilidad ósea posterior a los maléolos y capaz de caminar 4 pasos. ¿Se solicita radiografía?

REVERSO: No: los criterios de Ottawa son negativos, por lo que se evita la radiografía innecesaria; se inicia manejo conservador y propiocepción después de 72 horas.

Estrabismo

Tarjeta 1 -- FRENTE: Niño de 18 meses con desviación interna constante de un ojo, reflejo luminoso excéntrico y sin limitación de abducción. Diagnóstico y tratamiento inicial.

REVERSO: Estrabismo concomitante convergente (esotropía): corrección de errores refractivos con gafas; en menores de 24 meses la toxina botulínica A (5 U en cada recto interno) es primera opción. Diferencial: el paralítico cursa con limitación ocular (incomitante).

Tarjeta 2 -- FRENTE: Complicación más frecuente del estrabismo en la niñez.

REVERSO: Ambliopía (el 50% de los niños con estrabismo la desarrollan); se trata ocluyendo el ojo dominante con parche o midriasis con atropina, eficaz hasta ~6 años.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Desviación interna que no es evidente clínicamente hasta los 3-4 meses y es 5 veces más frecuente que su contraparte.

REVERSO: Esotropía (endotropía) concomitante; puede ser la manifestación inicial de ambliopía establecida, retinoblastoma o tumores de fosa posterior.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Parálisis del III nervio craneal: posición del ojo, pupilas y ptosis.

REVERSO: Exotropía con hipotropía, midriasis, ptosis y diplopía, con limitación de aducción, elevación y depresión; es el par más afectado en diabéticos.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Diplopía vertical que aumenta en aducción y depresión del ojo parético. Nervio afectado.

REVERSO: Nervio IV (par troclear): hipertropía del ojo parético con limitación para descender e intorsionar la mirada. Diferencial: VI = endotropía con limitación de abducción.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Desviación menor de 12 dioptrías prismáticas en estrabismo paralítico. Tratamiento.

REVERSO: Prismas (sin cirugía); parches oculares y ejercicios ortópticos como adyuvantes. La toxina botulínica NO se recomienda en el estrabismo paralítico.

Fistula Anal

Tarjeta 1 -- FRENTE: Drenaje persistente purulento por un orificio en la piel perianal, con dolor al ocluirse el conducto, tras un absceso anal drenado. Diagnóstico.

REVERSO: Fístula anal: trayecto epitelizado que comunica el conducto anal (orificio primario) con la piel perianal (secundario); se desarrolla en 40-80% (promedio 50%) tras un absceso anal.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Qué fístulas se consideran complejas?

REVERSO: Las que comprometen más de 30-50% del esfínter externo (transesfintérica alta, supraesfintérica o extraesfintérica), las anteriores en mujeres, con incontinencia, enfermedad de Crohn o cirugía anorrectal previa.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Tipo más frecuente según la clasificación de Parks.

REVERSO: Intersfinteriana (45%), entre ambos esfínteres; siguen transesfinteriana (29%), supraesfinteriana (20%) y extraesfinteriana (5%).

Tarjeta 4 -- FRENTE: Estudio de imagen de elección ante sospecha de fístula anal compleja y estándar de oro.

REVERSO: Ultrasonido de primera elección; la resonancia magnética es el estándar de oro. La manometría se indica si hay antecedente de incontinencia.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Tratamiento de elección de la fístula anal simple.

REVERSO: Fistulotomía con marsupialización (recurrencia 2-9%); la fistulectomía no es de primera línea por mayor incontinencia. En complejas: colgajos de avance endoanal y setones.

Tarjeta 6 -- FRENTE: ¿Justifica el uso de antibióticos tras el drenaje de un absceso anal para prevenir la fístula?

REVERSO: No; su utilización no está justificada. La fístula se forma por el drenaje del absceso en un 40-80% de los casos.

Fisura Anal

Tarjeta 1 -- FRENTE: Dolor anal desgarrador desencadenado por la defecación que dura horas, con escasa rectorragia rojo brillante en el papel. Diagnóstico y localización típica.

REVERSO: Fisura anal: úlcera lineal por desgarramiento del anodermo en la comisura posterior (74%); se extiende del margen anal a la línea dentada. Diferencial: si es lateral o múltiple, buscar Crohn, ITS, VIH o amebiasis.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Tríada de Brodie en la fisura anal crónica.

REVERSO: Papila anal hipertrófica, úlcera cutánea (la fisura) y colgajo cutáneo (hemorroide centinela).

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Por qué no se debe realizar tacto rectal en un paciente con fisura anal sospechada?

REVERSO: Porque es sumamente doloroso (la hipertonía del esfínter interno genera proctalgia e isquemia local que impide la cicatrización); la anoscopia sólo se realiza bajo anestesia.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Tratamiento farmacológico inicial de la fisura anal crónica.

REVERSO: Diltiazem tópico al 2%; alternativa el trinitrato de glicerilo tópico (cefalea en 25%). Ante falla de ambos: toxina botulínica.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Tratamiento de elección quirúrgico de la fisura anal y su complicación más temida.

REVERSO: Esfinterotomía lateral interna (abierta o cerrada); la complicación temida es la incontinencia. No se recomienda la dilatación anal manual.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Manejo de la fisura anal aguda (<6 semanas).

REVERSO: Incremento de líquidos y fibra, ablandadores fecales, baños de asiento y analgésicos tópicos; el desgarramiento es superficial con bordes limpios.

Fracturas

Tarjeta 1 -- FRENTE: Fractura diafisaria de húmero: nervio lesionado con mayor frecuencia.

REVERSO: Nervio radial (usualmente neuropraxia, reversible en 3-4 meses); también riesgo de lesión vascular con síndrome compartimental del antebrazo.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Fractura expuesta tipo III de tibia y peroné. Conducta quirúrgica.

REVERSO: Aseo y desbridamiento en las primeras 6 horas con fijación preferentemente con fijador externo temporal; cobertura cutánea en las primeras 72 horas. Diferencial: el clavo endomedular es de primera elección en las cerradas no aptas para manejo conservador.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Esquema antibiótico de elección en fractura expuesta Gustilo-Anderson tipo II.

REVERSO: Cefalotina + amikacina (primera elección); en tipo I sólo cefalotina; tipos IIIA-IIIC agregan penicilina y amikacina, y metronidazol en IIIA3, IIIB y IIIC.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Cadera de adulto mayor: extremidad acortada y en rotación externa notoria. Diagnóstico, estudio y analgésico de elección.

REVERSO: Fractura de cadera (fémur proximal): radiografía AP de pelvis ($\pm$ lateral); paracetamol es el analgésico de elección, y la tracción no está indicada.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Cuándo debe operarse una fractura de cadera y qué profilaxis se emplea?

REVERSO: De forma temprana, en las primeras 24-36 horas (disminuye morbilidad); profilaxis antibiótica con cefalosporina y tromboprofilaxis con heparina no fraccionada, enoxaparina o dalteparina (no ácido acetilsalicílico), de 14 a 35 días.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Signos de alarma de síndrome compartimental en fractura de tibia y su tratamiento.

REVERSO: Edema leñoso, dolor intenso progresivo, dolor al estiramiento pasivo o extensión de los ortos, parestesias y parálisis: dermofasciotomías urgentes de los cuatro compartimientos de la pierna.

Generalidades De La Atencion Del Paciente Politraumatizado

Tarjeta 1 -- FRENTE: Secuencia de la revisión primaria del paciente politraumatizado.

REVERSO: ABCDE: vía aérea con control cervical (A), respiración-ventilación (B), circulación con control de hemorragia (C), déficit neurológico (D) y exposición/ambiente (E, previniendo hipotermia).

Tarjeta 2 -- FRENTE: Causa de muerte prevenible más importante en el trauma.

REVERSO: La hemorragia; se controla inicialmente con presión y se sospecha en cavidades torácica, abdominal, retroperitoneal, pélvica y fracturas de huesos largos (tras descartar neumotórax a tensión).

Tarjeta 3 -- FRENTE: Paciente con hipotensión, ingurgitación yugular y auscultación pulmonar normal. Diagnóstico.

REVERSO: Taponamiento cardíaco; el neumotórax a tensión también cursa con ingurgitación, pero con abolición de los ruidos pulmonares (dato diferencial: la auscultación).

Tarjeta 4 -- FRENTE: Fármaco que mejora la supervivencia si se administra dentro de las primeras 3 horas de la lesión.

REVERSO: Ácido tranexámico, cuyo uso se mantiene durante la fase hospitalaria; su reanimación con cristaloides debe ser juiciosa (1 L adultos, 20 ml/kg niños) para evitar coagulopatía.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Tríada letal del trauma hemorrágico.

REVERSO: Coagulopatía, hipotermia y acidosis; se previene con reposición precoz de hemoderivados en hemorragias clase III-IV y calentamiento de soluciones a 37-40 °C.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Escala de gravedad del politrauma que se ha preguntado en el ENARM y su punto de referencia.

REVERSO: Revised Trauma Score (RTS): Glasgow + presión arterial sistólica + frecuencia respiratoria (12 mejor, 1 peor); un puntaje total <11 indica referencia a un centro especializado en trauma.

Hernias Discales

Tarjeta 1 -- FRENTE: Dolor lumbar irradiado a nalga, cara lateral de pantorrilla y dorso del pie, con pérdida del reflejo aquiliano. Raíz y nivel discal más frecuente.

REVERSO: Radiculopatía S1 (reflejo de Aquiles abolido); 90-95% de las radiculopatías compresivas ocurren en L4-L5 y L5-S1. Diferencial: L5 cursa con paresia de dorsiflexión y reflejo isquiotibial interno.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Signo de Laségue positivo entre 30 y 60 grados de flexión de cadera. Sensibilidad y especificidad.

REVERSO: Sensibilidad alta (83-91%) pero especificidad baja (26%); la elevación de la pierna recta contralateral (cruzada) tiene especificidad de 88% y sensibilidad de 29%.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Estudio de imagen de elección cuando está indicado en la radiculopatía lumbosacra y sus indicaciones urgentes.

REVERSO: Resonancia magnética; urgente si hay déficit neurológico progresivo, sospecha de cauda equina (incontinencia fecal, retención urinaria, anestesia en silla de montar), neoplasia o absceso epidural.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Tratamiento inicial de la hernia discal lumbosacra.

REVERSO: Conservador: AINE y paracetamol como fármacos de primera elección + higiene postural (modificar actividad extenuante sólo la primera semana); con fisioterapia de 6 semanas si persiste. A 2 años el resultado es indistinguible del quirúrgico.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Indicaciones de discectomía en hernia discal lumbosacra.

REVERSO: Síndrome de cauda equina, déficit neurológico severo o progresivo, y ausencia de mejoría tras 6 semanas de terapia conservadora con imagen correlacionada.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Paciente con hernia discal y electromiografía solicitada al inicio de los síntomas. ¿Es adecuada?

REVERSO: No: los estudios de conducción nerviosa y la EMG son útiles sólo 3 semanas o más después del inicio de los síntomas, para identificar causas no estructurales.

Hernias

Tarjeta 1 -- FRENTE: Hernia que pasa por dentro del triángulo de Hesselbach y nunca llega al escroto. Diagnóstico y diferencial anatómico.

REVERSO: Hernia inguinal directa ('de esfuerzo'); la indirecta ('congénita', por persistencia del proceso peritoneo-vaginal, la más frecuente: 2/3 de las inguinales) pasa por fuera del triángulo y llega al escroto. El riesgo en el varón es 25 veces mayor.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Hernia con la tasa más alta de estrangulación y su conducta recomendada.

REVERSO: Femoral o crural (15-20% de estrangulación): reparar todas las hernias femorales en cuanto se diagnostican.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Técnica quirúrgica de elección de la hernia inguinal y técnica recomendada si hay contaminación.

REVERSO: Plastia de Lichtenstein (malla, libre de tensión); ante encarcelamiento con resección intestinal o contaminación, reparación tisular con técnica de Shouldice.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Mujer con hernia umbilical y defecto >3 cm. Técnica recomendada.

REVERSO: Uso de material protésico (en defectos <3 cm, técnica de Mayo por vía abierta), preferentemente ambulatorio con anestesia regional. En niños: reparación si el defecto >1.5 cm o persiste después de los 2 años.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Hernia posincisional grande con vísceras fuera de la cavidad. Técnica de elección y riesgo de cierre sin malla.

REVERSO: Laparoscopia con malla como técnica de elección; abierta con separación de componentes (Rives/Rives-Stoppa). El cierre primario sin malla recidiva hasta en 54%.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Hernia hiatal con el fondo gástrico herniado junto a un esófago en posición normal. Tipo y riesgo.

REVERSO: Tipo II paraesofágica (5% de las hernias hiatales); el riesgo es la torsión e isquemia del segmento herniado (hasta 30%). Diferencial: la tipo I deslizante (95%) migra la unión gastroesofágica al tórax.

Hiperplasia Prostática Benigna

Tarjeta 1 -- FRENTE: Varón de 62 años con pujo miccional, chorro delgado e intermitente, sin complicaciones. Puntaje IPSS de 12. Tratamiento de primera línea.

REVERSO: Bloqueadores alfa (tamsulosina, terazosina, doxazosina, alfuzosina): primera línea en STUI moderados-severos; disminuyen síntomas pero no el tamaño prostático.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Fármaco que reduce el tamaño de la próstata en la HPB y su criterio de indicación.

REVERSO: Inhibidores de la 5-alfa reductasa (finasteride, dutasteride), indicados con próstata ≥ 40 g y/o APE >1.4 - 1.6 ng/ml; reducen el riesgo de intervención quirúrgica y de retención aguda.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Criterios para indicar tratamiento quirúrgico en HPB y procedimiento de elección.

REVERSO: Complicaciones (retención urinaria recurrente, infecciones recurrentes, hidronefrosis, insuficiencia renal, hematuria prostática) o síntomas moderados-severos refractarios: resección transuretral de próstata (próstatas 30-80 ml).

Tarjeta 4 -- FRENTE: Próstata de 90 ml con STUI severo. ¿Qué procedimiento se valora?

REVERSO: Prostatectomía abierta: las próstatas >80 ml no son candidatas a la resección transuretral.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Estudio de imagen útil en HPB para valorar orina residual y tamaño prostático.

REVERSO: Ultrasonido vesical y prostático; también identifica litiasis (en infecciones recurrentes) y tumores (en hematuria persistente). El diagnóstico inicial es clínico: tacto rectal + IPSS.

Tarjeta 6 -- FRENTE: ¿La HPB aumenta el riesgo de cáncer prostático?

REVERSO: No: no es considerada factor de riesgo ni lesión premaligna; los pacientes se evalúan anualmente con tacto rectal y APE porque la cirugía no elimina todo el tejido prostático.

Hipertension Intraocular Y Glaucoma

Tarjeta 1 -- FRENTE: Presión intraocular de 24 mm Hg medida con tonómetro de Goldmann, con nervio óptico y campos visuales normales. Diagnóstico y tratamiento.

REVERSO: Hipertensión intraocular (>21 mm Hg sin daño estructural ni funcional; >25-27 mm Hg = alto riesgo): iniciar análogos de prostaglandinas, con meta de reducción del 20% de la presión basal.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Ojo rojo, dolor severo, halos multicolores, náusea, vómito y globo ocular duro en una mujer hipermetrope de 60 años. Diagnóstico y tratamiento inicial.

REVERSO: Crisis aguda de glaucoma de ángulo cerrado: acetazolamida oral (tratamiento farmacológico inicial de elección) ± betabloqueadores, alfa-2 agonistas y manitol si la presión >50 mm Hg.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Tratamiento definitivo de la crisis aguda de ángulo cerrado y su ventana.

REVERSO: Iridotomía láser (o iridectomía incisional) realizada una vez resuelta la crisis, en las primeras 24-48 horas; el ojo contralateral asintomático con ángulo estrecho también recibe iridotomía.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Estudio de elección para evaluar el ángulo camerular en glaucoma de ángulo cerrado.

REVERSO: Gonioscopia (método diagnóstico de elección); ángulos ≤20° (grado II de Shaffer o menor) tienen riesgo potencial de cierre.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Tratamiento farmacológico inicial del glaucoma primario de ángulo abierto crónico.

REVERSO: Análogo de prostaglandinas tópico (latanoprost), el agente más eficaz; ante contraindicación, betabloqueador (timolol), y si no se alcanza la meta, dorzolamida o brimonidina. La pilocarpina está en desuso. Cursa con pérdida periférica del campo visual (escotoma de Bjerrum).

Tarjeta 6 -- FRENTE: Recién nacido con fotofobia, lagrimeo, córnea de diámetro >12 mm y estrías de Haab. Diagnóstico y tratamiento de primera intención.

REVERSO: Glaucoma congénito primario (bilateral en 70%, herencia autosómica recesiva): tratamiento quirúrgico de primera intención, goniotomía si el ángulo es visible o trabeculectomía si la córnea está opaca.

Hipoacusia

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Cuándo debe realizarse el tamizaje auditivo neonatal y con qué prueba se inicia?

REVERSO: En todos los niños antes del primer mes; la prueba inicial es la de emisiones otoacústicas; si falla, evaluación médica y audiológica antes de los 3 meses.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Pérdida auditiva unilateral mayor de 30 dB en tres frecuencias consecutivas, instaurada en menos de 72 horas. Diagnóstico y urgencia.

REVERSO: Hipoacusia neurosensorial súbita idiopática: emergencia otológica; iniciar tratamiento antes de los 30 días (idealmente en los primeros 10) es esencial para conservar la audición.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Tratamiento de elección de la hipoacusia neurosensorial súbita idiopática.

REVERSO: Corticoides, preferentemente en los primeros 10 días; la vía intratimpánica se usa en diabéticos o casos refractarios (mejor concentración en oído interno y menos efectos secundarios).

Tarjeta 4 -- FRENTE: Audiometría con mejor vía ósea que aérea. Tipo de hipoacusia y ejemplo.

REVERSO: Hipoacusia conductiva (transmisión afectada en oído externo o medio): otosclerosis, otitis media crónica. Diferencial: neurosensorial con mejor vía aérea que ósea (ototoxicidad, schwannoma VIII).

Tarjeta 5 -- FRENTE: Neonato prematuro con peso de 1,200 g y gentamicina por más de 5 días. ¿Qué se vigila y por qué?

REVERSO: Hipoacusia neurosensorial: son factores de riesgo (peso <1.5 kg, edad gestacional ≤32 semanas, ototóxicos >5 días o combinados con diuréticos de asa); corresponde tamizaje con emisiones otoacústicas.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Adulto mayor que oye pero no entiende, sobre todo con ruido ambiente; audiometría con hipoacusia neurosensorial para tonos agudos. Diagnóstico.

REVERSO: Presbiacusia; diferencial: la enfermedad de Menière cursa con vértigo recurrente y plenitud ótica, y la hipoacusia súbita tiene instalación en ≤72 horas.

Infeccion De Herida Y Sitio Quirurgico

Tarjeta 1 -- FRENTE: Herida quirúrgica de colecistectomía. Clase de herida y riesgo de infección.

REVERSO: Clase 2 (limpia-contaminada): se transgrede una barrera contaminada; riesgo de infección cercano al 8%, las que más se benefician de la profilaxis antibiótica. Diferencial: la clase 1 tiene ~1%.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuándo se administra la profilaxis antibiótica quirúrgica idealmente?

REVERSO: Durante la inducción anestésica, por vía intravenosa, 30-60 minutos antes de incidir la piel; su extensión a 24 horas reduce el riesgo de ISQ.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Definición CDC de infección del sitio quirúrgico.

REVERSO: Infección dentro de los primeros 30 días del procedimiento (hasta 1 año con implantes) que involucra piel o tejido profundo, con secreción purulenta, microorganismo identificado o datos clínicos de inflamación.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Paciente que pesa 90 kg. ¿Cómo se ajusta la dosis profiláctica de cefalosporina de primera generación?

REVERSO: Se duplica si pesa >80 kg y se triplica si pesa >120 kg; en obesidad también aumenta la dosis. Sangrado mayor (>1,500 ml) exige dosis extra tras reponer líquidos.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Medidas del posoperatorio que reducen la ISQ (glucemia, temperatura, oxígeno).

REVERSO: Glucemia <180 mg/dL en las primeras 18-24 horas, normotermia ≥ 35.5 °C y oxígeno suplementario (FiO₂ >30-35% o SatO₂ >95%); también HbA1c <7% preoperatoria en diabéticos.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Paciente colonizado por SAMR. ¿Cómo se descoloniza?

REVERSO: Gluconato de clorhexidina para la piel + mupirocina nasal.

Insuficiencia Venosa Cronica

Tarjeta 1 -- FRENTE: Venas abultadas y tortuosas en cara medial de pantorrilla, pesantez vespertina y edema que mejora con elevación. Diagnóstico y estudio de elección.

REVERSO: Insuficiencia venosa crónica (várices); el ultrasonido Doppler dúplex es el estudio no invasivo de elección, para diagnóstico, pronóstico y control post-tratamiento.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Clasificación que se debe utilizar en todo paciente con insuficiencia venosa crónica.

REVERSO: Nicolaidés (CEAP): Clínica (C0-C6), Etiología (Ec/Ep/Es), Anatómica (As/Ap/Af) y Fisiopatología (PR reflujo, PO obstrucción). C6 = úlcera activa.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Tratamiento conservador de la enfermedad venosa crónica y compresión mínima de las medias.

REVERSO: Ejercicio aeróbico, control de peso, elevación de piernas y medias de compresión graduada de al menos 22-29 mm Hg; está contraindicada con ITB <0.6 (isquemia arterial).

Tarjeta 4 -- FRENTE: Cirugía indicada ante fracaso de 6 meses del tratamiento conservador o várices complicadas.

REVERSO: Fleboextracción (parcial o completa) de la safena mayor con ligadura de las perforantes incompetentes. Diferencial: la escleroterapia se usa en varicosidades <3-5 mm sin reflujo de los troncos sáfenos.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Úlcera venosa activa. ¿Qué fármaco se indica hasta la cicatrización?

REVERSO: Pentoxifilina (hasta que cicatrice); los flebotónicos (diosmina, castaña de indias) se usan por 6 meses para síntomas, contraindicación quirúrgica o como coadyuvantes.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Úlceras que se comparan: localización proximal al maléolo interno, piel pigmentada, edema y dolor ausente o aliviado con elevación. Origen.

REVERSO: Úlcera de origen venoso (flebostática); diferencial: la arterial se localiza en orfejos y maléolos externos, con piel atrófica y dolor intenso aliviado con el declive; la neurotrófica, en puntos de presión sin dolor.

Lesiones De Rodilla

Tarjeta 1 -- FRENTE: Deportista con hemartrosis de rodilla y sensación de cedido. Lesión más probable y maniobras para confirmarla.

REVERSO: Ruptura del ligamento cruzado anterior (el 70% de las hemartrosis se asocian a LCA); confirmar con Lachman, cajón anterior y cambio de pivote.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Hallazgo radiográfico de avulsión ósea de la inserción del menisco tibial lateral tras trauma de rodilla.

REVERSO: Fractura de Segond, sugestiva de lesión del LCA. Diferencial: el signo del surco (fractura osteocondral femoral) se ve en <5% de los casos.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Estudio de elección ante sospecha de ruptura del LCA o LCP.

REVERSO: Resonancia magnética; el ultrasonido sirve para lesiones meniscales y de ligamentos colaterales, pero no para los cruzados.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Tratamiento de la ruptura del LCA y de las lesiones de LCP y colaterales grados I-II.

REVERSO: LCA: quirúrgico (sustitución) seguido de rehabilitación de 6 meses; LCP y colaterales I-II-III no severas: conservador con inmovilización en extensión por 3 semanas.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Trauma en valgo con ruptura de menisco medial, ligamento colateral medial y LCA. Nombre de la entidad.

REVERSO: Tríada de O'Donoghue ('tríada desgraciada'); el menisco medial se lesion 5-7 veces más que el lateral.

Tarjeta 6 -- FRENTE: ¿Cuándo se indica manejo conservador de una lesión meniscal?

REVERSO: Lesiones asintomáticas o leves sin bloqueo ni derrame, roturas longitudinales <1 cm y estables (desplazamiento ≤3 mm), roturas radiales <5 mm y lesiones en zona periférica; si no, sutura o menisectomía parcial artroscópica.

Lesiones Epifisarias Y Fracturas Especiales En El Paciente Pediatrico

Tarjeta 1 -- FRENTE: Clasificación de las lesiones epifisarias y su tipo más frecuente.

REVERSO: Salter-Harris; el tipo II (fractura-separación de la epífisis, lesión por cizallamiento y flexión) es el más frecuente, con tratamiento de reducción cerrada y pronóstico excelente.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Fractura de Salter-Harris que atraviesa toda la placa epifisaria desde la superficie articular hasta la metáfisis. Tratamiento y pronóstico.

REVERSO: Tipo IV (fractura del cóndilo humeral lateral): reducción abierta con fijación esquelética interna; pronóstico malo. Diferencial: tipo III (intraarticular hasta la placa) también requiere reducción abierta pero con buen pronóstico.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Aplastamiento de la placa epifisaria por compresión intensa. Tipo, visibilidad radiográfica y pronóstico.

REVERSO: Salter-Harris tipo V: difícil de ver en radiografía; tratamiento con evitación de carga 3 semanas y pronóstico malo por suspensión prematura del crecimiento.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Niño que cae sobre la palma de la mano: engrosamiento anular del radio distal sin fractura del lado opuesto. Diagnóstico y tratamiento.

REVERSO: Fractura en rodete (torus, 'caña de bambú'): incompleta y estable; yeso por ~3 semanas, sin secuelas.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Fractura incompleta del antebrazo con periostio intacto en la concavidad, inestable y con riesgo de desplazamiento. Diagnóstico y tratamiento.

REVERSO: Fractura en tallo verde: inmovilización con yeso o férula por 4-6 semanas con seguimiento (puede seguir desplazándose); difiere del rodete por ser inestable.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Sitio más frecuentemente afectado por las lesiones epifisarias y sexo predominante.

REVERSO: Radio distal (sigue la tibia distal); afectan más a varones y a la extremidad superior.

Lesiones Graves por Electricidad

Tarjeta 1 -- FRENTE: Obrero con quemadura por alta tensión y mano fuertemente cerrada con herida de entrada. ¿Qué sugiere y cuántos voltios se consideran alta tensión?

REVERSO: Lesión profunda de tejidos blandos mucho más extensa de lo externo observable: requiere fasciotomías y traslado a centro especializado. Alta tensión: mayor a 1000 voltios.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Paciente con lesión eléctrica y orina rojo oscuro. ¿Complicación esperada y manejo?

REVERSO: Rabdomiólisis con mioglobinuria (hemocromógenos) que causa lesión renal aguda: reanimación hídrica agresiva temprana con Ringer lactato, bicarbonato de sodio y manitol para solubilizar la mioglobina.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cuál es la fórmula de reanimación hídrica y la meta de uresis en la lesión eléctrica?

REVERSO: 4 mL/kg por % de superficie quemada con Ringer lactato; uresis: 1-1.5 mL/kg/hora en niños <30 kg o 100 mL/hora en adultos; al aclararse la orina, ajustar a 0.5 mL/kg/hora.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Lesión eléctrica con edema intenso, circulación distal comprometida y compartimentos tensos. ¿Conducta?

REVERSO: Escaro y fasciotomías inmediatas; si el compartimento muscular presenta necrosis extensa, amputación desde el inicio.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Qué complicación cardíaca y musculoesquelética debe anticiparse en la lesión por electricidad?

REVERSO: Arritmias cardíacas hasta paro cardíaco, y fracturas o luxaciones por contracción muscular forzada, sacudida o caída de altura.

Lesiones Por Exposición Al Frio

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Cómo se clasifica la hipotermia sistémica según la temperatura central?

REVERSO: Leve: 33-35°C; moderada: 30-32°C; grave: <30°C; en traumatizado se diagnostica hipotermia con temperatura <36°C y grave <32°C.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Qué grado de frostbite cursa con vesículas hemorrágicas y necrosis de todo el grosor de la piel?

REVERSO: Tercer grado (necrosis de piel y tejido subcutáneo); el cuarto involucra músculo y hueso; el segundo presenta vesículas con necrosis parcial de la piel.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cuál es el recalentamiento indicado en la lesión aguda por congelación de una extremidad?

REVERSO: Sumergir la parte afectada en agua circulante a 40°C hasta la reperusión (20-30 minutos) con analgésicos opioides; no masaje ni calor seco.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Por debajo de qué temperaturas se producen fibrilación ventricular y asistolia, y cuál es el único antiarrítmico efectivo en hipotermia?

REVERSO: Fibrilación <28°C y asistolia <25°C; el único antiarrítmico efectivo es el bretilio (la dopamina tiene cierta efectividad). No puede declararse muerte antes de recalentar al paciente.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Qué tipo de recalentamiento corresponde a la hipotermia leve y cuál a la moderada y grave?

REVERSO: Leve: pasivo (ropa seca y mantas, apoyando la termorregulación propia); moderada y severa: activo (soluciones IV calientes, apósitos en ingles y axilas, lavado peritoneal o toracopleural, derivación cardiopulmonar o hemodiálisis).

Tarjeta 6 -- FRENTE: Lesión dolorosa en pies húmedos por exposición repetida a temperaturas de 1.6 a 10°C. ¿Diagnóstico?

REVERSO: Pie de trinchera (inmersión en frío): lesión sin congelación por daño endotelial microvascular crónico, típica de soldados, marineros y pescadores; hiperemia a las 24-48 horas con dolor quemante y disestesia.

Litiasis Urinaria

Tarjeta 1 -- FRENTE: Dolor en flanco unilateral súbito, espasmódico e insoportable, con posición antiálgica y hematuria. ¿Diagnóstico y estudio de elección?

REVERSO: Cólico renoureteral por litiasis urinaria (80% oxalato de calcio): tomografía helicoidal no contrastada (estándar de oro); ultrasonido como estudio inicial en urgencias y en gestantes (primera elección).

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuál es el analgésico de primera línea del cólico renoureteral y con qué dosis?

REVERSO: Diclofenaco 75 mg intravenoso (o metamizol sódico 2 g IV en infusión lenta); si persiste a los 30 minutos: clonixinato de lisina 100 mg IV como rescate; opioides (morfina, tramadol) como segunda línea.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Qué antiemético se usa para náusea y vómito en el cólico renoureteral?

REVERSO: Ondansetrón 5 mg intravenoso.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Cálculo urinario de 7 mm. ¿Qué tratamiento expulsivo se indica?

REVERSO: Alfabloqueantes (tamsulosina) para litos de 5-10 mm; litos >20 mm requieren consulta urgente por Urología.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Lito de estruvita en contexto de infección urinaria. ¿Qué bacterias lo favorecen?

REVERSO: Bacterias productoras de ureasa: Proteus y Klebsiella (orina alcalina); composición de litos: oxalato de calcio #1 (80%), fosfato de calcio #2, ácido úrico 8%, estruvita 8% y cistina 2%.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Cálculos pielocalcicales <3 cc con vía excretora normal. ¿Tratamiento definitivo?

REVERSO: Litotricia extracorpórea con ondas de choque (también coraliformes hasta 7 cc); cálculos >7 cc con dilatación: nefrolitotomía percutánea.

Lumbalgia

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Cómo se clasifica la lumbalgia según su evolución temporal?

REVERSO: Aguda: <6 semanas; subaguda: 6-12 semanas; crónica: >12 semanas.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Paciente lumbálgico con paresia. ¿Qué sospecha confirma y qué maniobra se realiza?

REVERSO: Compresión radicular (su presencia prácticamente confirma el diagnóstico); maniobra de Lasègue. El dolor por lumbalgia común no sobrepasa la rodilla.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Paciente de 55 años con dolor lumbar en reposo, nocturno y continuo, con antecedente de cáncer. ¿Sospecha?

REVERSO: Lumbalgia por proceso neoplásico; signos de alarma: edad >50 años, neoplasia previa, síndrome constitucional, dolor en reposo, fiebre, inmunosupresión y osteoporosis.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Retención urinaria y anestesia en silla de montar en un paciente con dolor lumbar. ¿Diagnóstico?

REVERSO: Síndrome de cauda equina; constituye un signo de alarma de la lumbalgia.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Cuál es el fármaco de elección en la lumbalgia aguda y qué se agrega si no cede?

REVERSO: Paracetamol (agudo, subagudo y crónico); si no cede, AINE a dosis bajas por tiempo corto (segunda línea, ibuprofeno con menor riesgo gastrointestinal y protector gástrico) y relajante no benzodiazepínico (metocarbamol) ≤2 semanas.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Lumbalgia aguda inespecífica. ¿Está indicado el estudio radiológico?

REVERSO: No: 95% de los casos son inespecíficos; radiografía AP y lateral solo ante temperatura >38°C >48 h, osteoporosis, déficit sensitivo-motor, corticoides crónicos, sospecha de espondilitis o cáncer, trauma, edad >50 años o falta de respuesta >4-6 semanas.

Luxacion Glenohumeral

Tarjeta 1 -- FRENTE: Paciente que cayó apoyándose en la mano con el brazo en abducción y rotación externa; hombro en deformidad en charretera. ¿Diagnóstico?

REVERSO: Luxación glenohumeral anterior (>95% de las luxaciones; la luxación de hombro es la más frecuente del organismo y 75% en menores de 30 años). Diferencial: la posterior se sospecha tras descargas eléctricas o convulsiones.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Hipoestesia en la cara lateral del hombro y debilidad para abducir tras una luxación de hombro. ¿Nervio afectado?

REVERSO: Nervio axilar (circunflejo), inervador del deltoides y del redondo menor.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cuál es el tratamiento de la luxación anterior de hombro?

REVERSO: Reducción cerrada (manejo con maniobras de Arlt, Kocher, Cooper o Hipócrates) más vendaje de Velpeau por 2-4 semanas y rehabilitación.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Paciente con luxación de hombro que cursa sin pulso braquial. ¿Conducta?

REVERSO: Manejo quirúrgico: indica lesión de los vasos axilares (complicación vascular más frecuente).

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Cuál es la complicación más frecuente de la luxación glenohumeral anterior?

REVERSO: La recidiva, hasta en 30% de los casos.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Paciente con antecedente de convulsión y hombro doloroso en aducción y rotación interna con imposibilidad de rotación externa. ¿Diagnóstico?

REVERSO: Luxación glenohumeral posterior: aumenta el diámetro anteroposterior del hombro, no abduce más de 90°; requiere reducción cerrada, muchas veces con anestesia general, e inmovilización en discreta rotación

externa.

Materiales De Sutura

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Qué suturas son de elección para anastomosis vasculares y tejidos potencialmente contaminados y por qué?

REVERSO: Los monofilamentos: menor resistencia al paso por los tejidos y menor probabilidad de infección (los multifilamentos tienen mayor capilaridad y efecto sierra, mayor riesgo de infección).

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Por qué mecanismo se absorben las suturas naturales y las sintéticas?

REVERSO: Naturales (catgut): proteólisis, más agresiva para los tejidos; sintéticas (poliglactina 910, ácido poliglicólico): hidrólisis, menos agresiva.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cuál es el tiempo de absorción del poliglactina 910 (Vicryl) y del ácido poliglicólico (Dexon)?

REVERSO: Poliglactina 910: 42 días (hidrólisis); ácido poliglicólico: 90 días; polidioxanona (PDS): 180 días; poliglecaprone 25 (Monocryl): 90-120 días; catgut: 80-90 días por proteólisis.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Qué sutura conserva mejor su fuerza tensil en las primeras semanas?

REVERSO: Las sintéticas: poliglactina 910 conserva 50% a 2-3 semanas; catgut solo 0-2-3% a 2-3 semanas (mala fuerza tensil).

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Qué material de sutura tiene mínima reacción tisular y muy buena fuerza tensil?

REVERSO: Acero inoxidable (reacción tisular baja, capilaridad mínima); la seda, en cambio, causa reacción tisular alta con capilaridad elevada.

Tarjeta 6 -- FRENTE: ¿Cómo se leen los calibres de sutura según la USP?

REVERSO: A mayor número tras el cero (2/0, 3/0, 4/0), más delgado el hilo; se recomienda el diámetro mínimo que permita buena tensión (a menor diámetro, menor traumatismo tisular).

Mordeduras y Picaduras

Tarjeta 1 -- FRENTE: Mordedura de gato con celulitis. ¿Qué germen predomina y cuál es el antibiótico empírico de elección?

REVERSO: Pasteurella multocida (colmillos afilados que inoculan profundo: mayor riesgo infeccioso); antibiótico de elección: amoxicilina/ácido clavulánico. Mordedura humana: Eikenella corrodens.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Paciente alérgico a penicilina con mordedura infectada. ¿Qué esquema se emplea?

REVERSO: Doxiciclina más metronidazol, o clindamicina más trimetoprim/sulfametoxazol; no cierre primario de heridas infectadas o en zonas de riesgo (manos, cara).

Tarjeta 3 -- FRENTE: Niño picado por alacrán con diaforesis, sialorrea, taquicardia e hipertensión. ¿Grado y tratamiento?

REVERSO: Grado III (escorpionismo por Centruroides): antídoto (faboterapia, Alacramyn) más manejo en UCI; grado I-II solo analgésicos y vigilancia; en menores de 5 años antídoto inmediato.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Lesión en ojo de buey con centro necrótico y hemólisis tras picadura de araña. ¿Agente, mecanismo y tratamiento?

REVERSO: Loxosceles reclusa (violinista): esfingomielinasa-D con necrosis y hemólisis; dapsona en las primeras 48 horas (inhibe migración neutrofílica) más corticoides y desbridación diferida.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Picadura de abeja con urticaria generalizada, broncoespasmo e hipotensión.
¿Tratamiento inmediato?

REVERSO: Epinefrina intramuscular 0.3-0.5 mg cada 5-15 minutos, oxígeno, líquidos IV, antihistamínicos H1 más H2 y esteroides IV; observación 4-6 horas por reacción de rebote.

Tarjeta 6 -- FRENTE: ¿Cuál es el esquema de profilaxis postexposición antirrábica?

REVERSO: Lavado inmediato con agua y jabón; si herida tipo III o animal sospechoso: vacuna más inmunoglobulina antirrábica humana (20 UI/kg); esquema días 0, 3, 7 y 14 intramuscular.

Orzuelo

Tarjeta 1 -- FRENTE: Pápula dolorosa con absceso en el borde palpebral de un paciente con blefaritis crónica.
¿Diagnóstico y etiología?

REVERSO: Orzuelo: infección estafilocócica de las glándulas de Zeiss-Moll (drenaje externo hacia la piel) o de Meibomio (drenaje interno hacia la conjuntiva tarsal). Dato diferencial: pústula dolorosa en el borde palpebral con absceso que drena a piel o conjuntiva.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuál es el manejo inicial del orzuelo?

REVERSO: Compresas calientes 3-4 veces al día por 5-10 minutos más aseo del borde palpebral e higiene con champú infantil o bicarbonato de sodio dos veces al día.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Qué antibióticos tópicos se emplean en el orzuelo y con qué esquema?

REVERSO: Cloranfenicol o eritromicina tópicos cada 8 horas por 7 días; no se justifica la vía sistémica de rutina.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Cuándo se indica antibiótico sistémico en el orzuelo?

REVERSO: Solo en cuadro grave o recurrente: dicloxacilina o eritromicina sistémicas; las lesiones persistentes pueden requerir drenaje quirúrgico.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Qué factores de riesgo predisponen al orzuelo?

REVERSO: Blefaritis crónica, rosácea, diabetes mellitus, dermatitis seborreica, inmunodepresión y embarazo.

Pancreatitis Aguda

Tarjeta 1 -- FRENTE: Dolor epigástrico súbito en hemicinturón hacia la espalda con lipasa >3 veces el límite superior. ¿Diagnóstico y marcador de elección?

REVERSO: Pancreatitis aguda (2 de 3 criterios: clínica, enzimas >3x o imagen): la lipasa sérica es el marcador más sensible y específico (se eleva 4-8 horas, persiste 7-14 días). Diferencial: perforación de úlcera péptica con aire libre.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuál es la causa más frecuente de pancreatitis aguda y qué laboratorio sugiere etiología biliar?

REVERSO: Litiasis biliar (49-66% de los casos); TGP >150 U/l es altamente sugestivo de pancreatitis biliar; razón lipasa/amilasa >2 sugiere etiología alcohólica.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Paciente con pancreatitis y equimosis periumbilical y en flanco. ¿Qué signos son?

REVERSO: Signo de Cullen (periumbilical) y de Grey-Turner (flanco): hemorragia intraabdominal; junto con dolor a la descompresión, hipoactividad peristáltica y ascitis son signos de gravedad.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Cuál es el estándar de oro de imagen en la pancreatitis aguda y cuándo detecta la necrosis?

REVERSO: Tomografía computarizada abdominal dinámica con contraste; la necrosis pancreática solo se detecta con TC contrastada entre 72 y 96 horas del inicio de los síntomas.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Qué se recomienda para la reanimación hídrica en pancreatitis aguda?

REVERSO: Cristaloideos (Ringer lactato o Hartmann) a 5-10 mL/kg/hora con metas: FC <120 lpm, PAM 65-85 mmHg, diuresis >0.5-1 mL/kg/hora y hematocrito 33-44%.

Tarjeta 6 -- FRENTE: ¿Cómo se maneja la pancreatitis aguda: analgesia, nutrición y antibióticos?

REVERSO: Analgesia por escalones (AINE, luego meperidina/morfina/tramadol); nutrición enteral temprana (<72 h, ideal 24-48 h) baja en grasas. Sin profilaxis antibiótica; en necrosis infectada: imipenem (mejor penetración pancreática). Colectomía laparoscópica por pancreatitis biliar en la misma hospitalización.

Pie Equino Varo Pie Zambo

Tarjeta 1 -- FRENTE: Neonato con pie dirigido hacia la línea media en inversión: flexión plantar, talón desviado hacia adentro y aducción del antepié. ¿Diagnóstico y componentes?

REVERSO: Pie equino varo (pie zambo), deformidad congénita más frecuente del pie (2/1000 neonatos; varones 2:1; bilateral 50%); pie equino + pie varo + metatarso aducto.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Qué huesos del tarso están hipotrofiados en el pie zambo displásico?

REVERSO: Astrágalo, escafoides y calcáneo (deformidad displásica con huesos de menor tamaño).

Tarjeta 3 -- FRENTE: Pie zambo tipo III (displásico duro): ¿se corrige clínicamente y qué probabilidad de recurrencia tiene?

REVERSO: No se corrige clínicamente a la línea media, siempre requiere cirugía y recidiva en 35% de los casos; el postural se corrige casi sin cirugía.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Cuál es el primer estudio diagnóstico del pie equino varo y cuál es el estándar de oro del tratamiento conservador?

REVERSO: Radiografías (asistidas con plantilla de acrílico o marco de madera); estándar de oro conservador: cirugía mínima de Ponseti (tenotomía percutánea del Aquileo) tras escayolas en los primeros 3 meses.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Con qué trastornos se asocia el pie zambo teratológico?

REVERSO: Espina bífida, bandas constrictoras congénitas (displasia de Streeter), artrogriposis, enanismos y síndrome de Múbius.

Pinguecula Y Pterigion

Tarjeta 1 -- FRENTE: Campesino de 35 años con proliferación fibrosa conjuntival que avanza hacia la córnea con una línea café. ¿Diagnóstico?

REVERSO: Pterigión: crecimiento fibrovascular que se extiende de la conjuntiva bulbar hacia la córnea, con línea de Stocker (café por hemosiderina). Diferencial: la pingüecula es degenerativa del limbo y no invade la córnea.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuál es el principal factor de riesgo del pterigión?

REVERSO: Exposición a rayos ultravioleta; también sequedad ocular, climas cálidos y secos, irritantes, inmunol alergias y tabaquismo.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cuál es el manejo médico inicial del pterigión?

REVERSO: Prednisolona, nafazolina, metilcelulosa y ciclosporina (control sintomático).

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Cuándo se indica cirugía en el pterigión y en qué consiste?

REVERSO: Si el manejo médico no controla síntomas o hay astigmatismo, ectopia de la carúncula o pérdida del pliegue semilunar: resección del pterigión más autoinjerto, con prednisolona y cloranfenicol posteriores.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Qué son las islas de Fuchs en el pterigión?

REVERSO: Pequeñas opacidades en la membrana de Bowman que traducen aumento de la actividad inflamatoria y de los síntomas.

Platipodia Con Espasmo Peroneo Coalicion Tarsal

Tarjeta 1 -- FRENTE: Adolescente con dolor en retropié, esguinces de tobillo frecuentes, valgo del retropié y limitación del movimiento subtalar. ¿Diagnóstico?

REVERSO: Coalición tarsal (platipodia con espasmo peroneo): falla de segmentación entre huesos tarsales, síntomas desde la adolescencia. Diferencial: el pie plano flexible es asintomático y conserva el movimiento subtalar.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuáles son las coaliciones tarsales más frecuentes?

REVERSO: La unión astrágalo-calcáneo y la calcáneo-escafoides; bilateral en más de la mitad de los casos.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cuál es el estudio de elección en las coaliciones tarsales?

REVERSO: Tomografía computarizada (especialmente las de la cara medial); diagnóstico inicial con radiografías AP, lateral en bipedestación y oblicua a 45°.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Cuál es el tratamiento conservador de la coalición tarsal?

REVERSO: Inmovilización con escayola por 6 semanas, insertos en el calzado u órtesis; si fracasa: escisión de la coalición con interposición de tejido blando.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Qué hallazgos exploratorios caracterizan la coalición tarsal?

REVERSO: Valgo progresivo del retropié, aplanamiento del arco, limitación del movimiento subtalar, dolor con la inversión del pie y tensión (sin espasmo verdadero) de los peroneos.

Platipodia Hipermovil Pie Prono

Tarjeta 1 -- FRENTE: Niño de 4 años con pie plano bilateral, flexible y asintomático. ¿Qué actitud corresponde?

REVERSO: Ningún tratamiento: >95% de los casos son asintomáticos y se corrigen con la maduración esquelética (~6 años); zapatos ortopédicos, plantillas y ejercicios no han demostrado efectividad.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Qué maniobra exploratoria corrige la deformidad del pie plano flexible?

REVERSO: Prueba de Rose: la hiperextensión del primerORTEJO corrige la deformidad; el talón va hacia afuera. Diferencial: el pie plano rígido no se corrige y es doloroso.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Hasta qué edad no puede confirmarse el diagnóstico de platipodia hipermóvil?

REVERSO: Hasta los ~6 años, cuando se corrige con la maduración esquelética.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Qué síndromes se asocian con pie plano grave?

REVERSO: Trisomía 21 y los síndromes de Ehlers-Danlos y de Marfán; causas principales: hiperlaxitud ligamentaria y sobrepeso.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Cómo se distingue el pie plano flexible del rígido?

REVERSO: El rígido o doloroso se debe a acortamiento o espasticidad del tendón de Aquiles, alteraciones congénitas, patología subastragalina o artritis reumatoide juvenil; el flexible es asintomático y bilateral.

Tarjeta 6 -- FRENTE: ¿Está indicada la radiografía en el pie plano flexible asintomático?

REVERSO: No: el diagnóstico es clínico (plantoscopia) y el estudio radiográfico usualmente no está indicado en casos asintomáticos.

Poliposis Nasosinusal

Tarjeta 1 -- FRENTE: Varón de 42 años con obstrucción nasal bilateral, hiposmia y masa en grises rosadas con aspecto de uva en el meato medio. ¿Diagnóstico?

REVERSO: Poliposis nasosinusal: tumores benignos más comunes de la cavidad nasal; nacen de la pared lateral nasal y del meato medio, usualmente bilaterales. Diferencial: la malignidad requiere tomografía para complementación.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Con qué condiciones se asocia la poliposis nasal?

REVERSO: Alergia (asma, rinitis alérgica: 25% de los riniticos tienen poliposis), fibrosis quística y tríada de Sampter.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cuál es el tratamiento inicial de la poliposis nasosinusal?

REVERSO: Corticoides tópicos (mejoran obstrucción y olfato) más lavados nasales con solución salina isotónica; corticoides sistémicos solo si no hay mejoría con los tópicos.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Cómo se confirma el diagnóstico de poliposis nasal?

REVERSO: Nasofibroscopia (evidencia de pólipos) más tomografía computarizada; el diagnóstico es fundamentalmente clínico.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Cuáles son las complicaciones más temidas de la resección quirúrgica de pólipos nasales?

REVERSO: Absceso cerebral, meningitis y trombosis del seno cavernoso; las principales: hemorragia, sinequias y perforaciones septales.

Tarjeta 6 -- FRENTE: ¿En qué consiste la tríada de Sampter?

REVERSO: Alergia al ácido acetilsalicílico, asma y poliposis nasal; además del tratamiento farmacológico requieren medidas dietéticas.

Presbicia

Tarjeta 1 -- FRENTE: Varón de 48 años que para leer necesita alejar el texto a más de 30 cm. ¿Qué padecimiento corresponde?

REVERSO: Presbicia: disminución fisiológica de la acomodación a partir de los 40-45 años que limita la visión cercana. Diferencial: a diferencia de la miopía, el paciente aleja (no acerca) el texto.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuál es el tratamiento de la presbicia?

REVERSO: Lentes bifocales para lograr la adición (suma del poder para visión cercana al poder para visión lejana).

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Qué dos datos son necesarios para el adecuado tratamiento con anteojos de la presbicia?

REVERSO: La edad del paciente y su distancia de trabajo.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿A partir de qué edad aparece la presbicia y por qué?

REVERSO: Generalmente a partir de los 40-45 años: es una disminución fisiológica de la capacidad de acomodación, no un defecto de refracción patológico.

Quemaduras (nuevo)

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Qué regla evalúa la extensión de la quemadura en adultos y cuál en niños?

REVERSO: Adultos: regla de los nueve de Wallace (cabeza y cuello 9%, cada extremidad superior 9%, cada inferior 18%, genitales 1%); niños: esquema de Lund and Browder. La palma del paciente (incluidos los dedos) equivale a 1%.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuál es la fórmula de reanimación hídrica en el adulto quemado y su distribución temporal?

REVERSO: 2 mL/kg por % de superficie corporal quemada (2° y 3° grado, quemadura >20%) con Ringer lactato: 50% en las primeras 8 horas y 50% en las siguientes 16; niños <14 años o <30 kg: 3 mL/kg por %.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cuál es la fórmula de reanimación hídrica del paciente quemado y su meta de gasto urinario?

REVERSO: Adultos: 2 mL/kg por %SCQ (2°-3° grado, >20%) con Ringer lactato: 50% en las primeras 8 horas y 50% en las siguientes 16; niños <14 años o <30 kg: 3 mL/kg por %. Meta: 0.5 mL/kg/hora o 30-50 mL/hora en adultos; 1 mL/kg/hora en niños.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Quemadura acartonada blanca-negra e insensible al pinchazo. ¿Grado y conducta?

REVERSO: Tercer grado (espesor total): no cura espontáneamente, requiere injerto y siempre deja cicatriz; criterio de referencia. El segundo grado superficial es muy doloroso, con ampollas, y cura <14 días.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Quemadura por ácido fluorhídrico con dolor intenso. ¿Tratamiento específico y riesgo?

REVERSO: Irrigación abundante más gel de gluconato de calcio al 2.5% (cambiar cada 15 min hasta ceder el dolor); si reaparece: gluconato de calcio al 10% intradérmico o intraarterial; riesgo de hipocalcemia y arritmias mortales (vigilar QT).

Tarjeta 6 -- FRENTE: ¿Qué fórmula de reanimación corresponde a la quemadura eléctrica y cuál es su meta de uresis?

REVERSO: 4 mL/kg por %SCQ con Ringer lactato; uresis 1-1.5 mL/kg/hora en niños <30 kg o 100 mL/hora en adultos, hasta aclarar la orina; luego ajustar a 0.5 mL/kg/hora. Con bicarbonato y manitol para solubilizar la mioglobina.

Quemaduras

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Qué fórmula se usa para valorar la extensión de la quemadura en adultos y cuál en niños?

REVERSO: Adultos: regla de los 9 de Wallace; niños: esquema de Lund and Browder.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuál es la fórmula de reanimación hídrica en el adulto quemado y su distribución?

REVERSO: 2 mL/kg por % de superficie quemada (2° y 3° grado) con Ringer lactato: 50% en las primeras 8 horas y 50% en las siguientes 16; en menores de 14 años o <30 kg: 3 mL/kg por %. Primer grado: no se calcula reposición.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cuál es la meta de uresis en el paciente quemado?

REVERSO: 0.5 mL/kg/hora o 30-50 mL/hora en mayores de 14 años y adultos; 1 mL/kg/hora en menores de 14 años o peso <40 kg.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Quemadura con color blanco-negro, apariencia acartonada y no dolorosa. ¿Grado y tratamiento?

REVERSO: Tercer grado (espesor total, destrucción de nervios): no cura espontáneamente, requiere injerto y siempre deja cicatriz. Diferencial: el segundo grado superficial es muy doloroso y cura <14 días.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Quemadura húmeda y roja que palidece a la presión sin ampollas. ¿Grado, pronóstico y reposición hídrica?

REVERSO: Primer grado (epidérmica): cura en <7 días sin cicatriz y no requiere cálculo de reposición hídrica según superficie.

Tarjeta 6 -- FRENTE: ¿Qué define al paciente gran quemado?

REVERSO: Índice de gravedad >70 o quemaduras de 2°-3° grado en >20% de la superficie corporal; también menores de 2 años o mayores de 65 años con >10%, quemaduras respiratorias, eléctricas de alta tensión, politraumatismo o enfermedad grave asociada.

Retinoblastoma

Tarjeta 1 -- FRENTE: Niño de 2 años con leucocoria detectada en la prueba de Bruckner. ¿Diagnóstico más probable?

REVERSO: Retinoblastoma: tumor intraocular maligno más frecuente de la infancia (0-4 años), del neuroectodermo; leucocoria es el signo más frecuente. Diferencial de leucocoria: catarata, vitreo primario hiperplásico persistente, enfermedad de Coats, toxocariosis.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Qué gen está implicado en el retinoblastoma y qué cromosoma?

REVERSO: Gen supresor Rb en el cromosoma 13q14 (mutado en 90% de los casos); prototipo de cáncer por mutación de un gen supresor con transmisión autosómica dominante y penetrancia de 100% en las formas hereditarias (40%).

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cuál es el estudio considerado estándar de oro para el diagnóstico del retinoblastoma?

REVERSO: La tomografía computarizada (la más útil para la extensión extraocular); el ultrasonido en modo A/B detecta tumores <2 mm y depósitos de calcio. No se recomienda PAAF por riesgo de diseminación.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Retinoblastoma unilateral focal. ¿Cuál es el tratamiento más seguro?

REVERSO: Enucleación; única indicación absoluta: posible afectación del nervio óptico (también siembras vítreas). No enucleación bilateral en el mismo tiempo quirúrgico.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Retinoblastoma bilateral de grupos C y D. ¿Cuál es la conducta?

REVERSO: Evaluación de la respuesta a 2 ciclos de quimioterapia neoadyuvante y preservación del ojo con mejor respuesta; quimiorreducción con carboplatino-vincristina-etopósido más terapia focal (fotocoagulación, crioterapia).

Tarjeta 6 -- FRENTE: Niño curado de retinoblastoma hereditario. ¿Qué segunda neoplasia debe vigilarse?

REVERSO: Osteosarcoma (segunda neoplasia asociada más frecuente); metástasis en el primer año si ocurrirán y curado si pasan 5 años sin metástasis; supervivencia >95% con manejo oportuno.

Rinitis Alérgica

Tarjeta 1 -- FRENTE: Paciente con estornudos, prurito nasal y ocular, rinorrea hialina y mucosa rosado-azulada, que se frota la nariz en saludo alérgico. ¿Diagnóstico y mecanismo?

REVERSO: Rinitis alérgica: inflamación mediada por IgE (hipersensibilidad tipo I, mastocitos); condición atópica más prevalente (10-20% de la población), 80% inicia antes de los 20 años.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuál es el diagnóstico definitivo de la rinitis alérgica y qué prueba es la más sensible?

REVERSO: Confirmación de IgE específica: pruebas cutáneas por punción (SPT, más sensibles, sensibilidad 85-87%, especificidad 79-86%); SPT está contraindicada en asma grave o no controlada.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Qué fármacos son de primera línea en la rinitis alérgica?

REVERSO: Antihistamínicos orales o nasales (segunda generación: levocetirizina, desloratadina, ebastina o fexofenadina, cuando predominan estornudos y prurito).

Tarjeta 4 -- FRENTE: Rinitis alérgica con síntomas persistentes moderados a severos que afectan la calidad de vida. ¿Tratamiento de elección?

REVERSO: Esteroides nasales (fluticasona, budesonida, mometasona o triamcinolona); montelukast se añade en pacientes con asma que no responden a primera línea.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Cuál es el único tratamiento que modifica la historia natural de la rinitis alérgica?

REVERSO: Inmunoterapia sublingual o subcutánea con alérgenos; no iniciarse en asma severa, inestable o no controlada. Los acaricidas son la medida ambiental más eficaz contra los ácaros.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Paciente con rinitis alérgica, síntomas obstructivos persistentes e hipertrofia de cornetes pese al tratamiento. ¿Referencia?

REVERSO: Otorrinolaringología para reducción de cornetes inferiores.

Tiron Del Codo Codo De Niñera

Tarjeta 1 -- FRENTE: Niño de 4 años fue levantado de la mano; ahora llora y rehúsa usar el brazo con radiografía normal. ¿Diagnóstico?

REVERSO: Tirón del codo (síndrome de pronación dolorosa o codo de niñera): subluxación transitoria de la cabeza radial; pico entre los 3 y 5 años. Diferencial: fractura de cuello radial (radiografía anormal).

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuál es el mecanismo de lesión del codo de niñera?

REVERSO: Tracción súbita del brazo en hiperextensión y pronación (jalar, levantar de la mano o de la muñeca, o balancear al niño).

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Qué hallazgo exploratorio caracteriza el tirón del codo?

REVERSO: Llanto, rehúsa usar el brazo y lo protege con el codo flexionado; limitación dolorosa de la supinación del antebrazo. La radiografía es normal.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Cuál es el tratamiento del tirón del codo?

REVERSO: Reducción mediante extensión del codo con supinación simultánea del brazo; después el niño usa el brazo espontáneamente. Cabestrillo 2 días si es necesario.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Qué estructura se lesiona en el codo de niñera?

REVERSO: El ligamento anular en su inserción distal en el cuello radial, con subluxación transitoria de la cabeza radial.

Torsion Testicular

Tarjeta 1 -- FRENTE: Adolescente con dolor escrotal agudo intenso, náusea y vómito de inicio súbito; reflejo cremastérico ausente y Prehn negativo. ¿Diagnóstico?

REVERSO: Torsión testicular (16% de las causas de escroto agudo, tras torsión de apéndices 46% y orquiepididimitis 35%); rotación del cordón espermático con pérdida de perfusión. Diferencial: orquiepididimitis

con Prehn positivo.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuál es el estudio de elección cuando la exploración no es definitiva en la torsión testicular?

REVERSO: Ultrasonido Doppler: muestra disminución o pérdida de la vascularidad; a las 4-6 horas testículo agrandado y heterogéneo por edema, hemorragia y necrosis.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cuál es la deformidad anatómica predisponente a la torsión testicular intravaginal?

REVERSO: Deformidad en badajo de campana: envoltura anormal del cordón con la túnica vaginal que permite la movilidad excesiva del testículo (causa más frecuente).

Tarjeta 4 -- FRENTE: Masa inguinal dolorosa con hemiescroto vacío. ¿Qué debe sospecharse?

REVERSO: Torsión testicular sobre testículo criptorquídico; la fijación inadecuada (orquidopexia o biopsia previa) también predispone.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Cuál es el tratamiento de la torsión testicular?

REVERSO: Todos requieren exploración quirúrgica con orquidopexia; la destorsión manual es puente si hay retraso quirúrgico (no sustituye la cirugía y está contraindicada en neonatos).

Tarjeta 6 -- FRENTE: ¿Cuál es la tasa de salvamento testicular según el tiempo de evolución de la torsión?

REVERSO: 90-100% en las primeras 6 horas; 50% después de 12 horas y 10% después de 24 horas (necrosis asociada a dolor de 4-8 horas).

Tracoma

Tarjeta 1 -- FRENTE: Niño preescolar de zona rural endémica con conjuntivitis folicular crónica y pannus de la mitad superior de la córnea. ¿Diagnóstico y etiología?

REVERSO: Tracoma: queratoconjuntivitis crónica por serotipos A, B y C de *Chlamydia trachomatis*; principal causa de ceguera infecciosa en el mundo (vector: mosca *Sorbus*; región endémica: Chiapas).

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuál es la estrategia SAFE de la OMS contra el tracoma?

REVERSO: Cirugía para triquiasis, antibióticos para el tracoma activo, limpieza facial y saneamiento ambiental.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Qué antibiótico es el tratamiento recomendado por la OMS para el tracoma y cuál es la alternativa?

REVERSO: Azitromicina en dosis única oral; alternativa (embarazadas, menores de 6 meses o alergia a macrólidos): ungüento de tetraciclina al 1% por 6 semanas. Éxito constatable al mes.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Paciente con tracoma en estadio III (precicatricial). ¿Qué complica la triquiasis y cuándo es quirúrgica?

REVERSO: Entropión y triquiasis con erosiones corneales; manejo quirúrgico si >1 pestaña roza la córnea al mirar al frente, hay daño corneal o molestia severa (oftalmólogo, segundo nivel).

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Cuál es el estándar de oro para identificar *Chlamydia trachomatis* en el tracoma?

REVERSO: La PCR; sin embargo, no confirma el diagnóstico de tracoma. La prueba más utilizada, pese a su baja sensibilidad, es la tinción de Giemsa.

Trastornos De La Via Biliar

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Cuál es el estudio de elección para la colelitiasis y cuál es el tratamiento de elección de la colelitiasis sintomática?

REVERSO: Ultrasonido abdominal (sensibilidad 98%); tratamiento de elección: colecistectomía laparoscópica. El cólico biliar dura 20 min-4 h y remite en <24 h con diclofenaco IM.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuál es el estudio de primera elección para confirmar la colecistitis aguda y cuál es el siguiente si no es concluyente?

REVERSO: Ultrasonido (pared >5 mm, líquido perivesicular, Murphy sonográfico positivo); siguiente: escintografía con ácido hidroxiiminodiacético (sensibilidad 97%), que muestra ausencia de llenado vesicular.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Colecistitis litiasica aguda: ¿cómo se confirma el diagnóstico y cuál es el tratamiento?

REVERSO: Ultrasonido de primera elección (pared >5 mm, Murphy sonográfico positivo, líquido perivesicular); si no es concluyente: escintografía con ácido hidroxiiminodiacético (sensibilidad 97%, sin llenado vesicular). Tratamiento: colecistectomía laparoscópica temprana en grado I-II (primeros 7 días, idealmente antes del 4º día).

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Cuál es el estudio de elección y el estándar de oro en la coledocolitiasis y en la colangitis?

REVERSO: Estudio de elección: colangiopancreatografía por resonancia magnética; estándar de oro: CPRE (diagnóstica y terapéutica); el ultrasonido es el estudio inicial (vía biliar >6 mm).

Tarjeta 5 -- FRENTE: Anciana con obstrucción intestinal, lito en intestino, niveles hidroaéreos y neumobilia en radiografía. ¿Diagnóstico?

REVERSO: Íleo biliar por fístula colecistoentérica (síndrome de Mirizzi tipo V): tríada de Rigler (lito en intestino, niveles hidroaéreos y neumobilia); tercera causa de íleo en adultos mayores, mortalidad ~20%.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Ictericia indolora progresiva en un varón >65 años. ¿Qué cáncer se sospecha y dónde se localiza el 50%?

REVERSO: Colangiocarcinoma (adenocarcinoma en 95%): 50% en la bifurcación del conducto hepático (tumor de Klatskin); primera manifestación en 90%: ictericia sin dolor. CA 19-9 >130 U/ml con sensibilidad de 79%.

Trauma Abdominal (nuevo)

Tarjeta 1 -- FRENTE: Politraumatizado inestable con FAST positivo. ¿Conducta?

REVERSO: Laparotomía exploratoria; el FAST evalúa 4 ventanas: saco pericárdico, espacio de Morrison, fosa esplenorenal y saco de Douglas, con control a los 30 minutos para detectar hemoperitoneo progresivo.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Apuñalamiento abdominal: ¿qué órgano se laceró con mayor frecuencia?

REVERSO: Hígado (40%); el proyectil de arma de fuego involucra más al intestino delgado (50%) y colon (40%); en trauma cerrado el más lacerado es el bazo (40-55%).

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cuál es la única contraindicación absoluta del lavado peritoneal diagnóstico y cuándo es positivo?

REVERSO: Indicación clara de laparotomía; positivo con >100,000 eritrocitos/μL, 500 leucocitos/μL o bacterias en tinción de Gram (sensibilidad 98%); aspiración de sangre fresca en inestable obliga laparotomía.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Qué se considera una prueba positiva del LPD? (revisión)

REVERSO: >100,000 eritrocitos/μL o 500 leucocitos/μL o bacterias en Gram; lavado con 1000 mL de solución isotónica (10 mL/kg en niños) tras descompresión gástrica y urinaria.

Tarjeta 5 -- FRENTE: TAC con líquido libre sin lesión hepática ni esplénica. ¿Qué conducta?

REVERSO: Sugiere lesión del tracto gastrointestinal y/o mesenterio: laparotomía exploratoria temprana; la TAC es el estudio de elección en el paciente estable.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Sangre en el meato uretral y equimosis perineal tras trauma. ¿Conducta antes de colocar sonda vesical?

REVERSO: Sospecha de desgarro uretral: confirmar integridad con uretrografía retrógrada antes de cateterizar (lesión uretral: sonda suprapúbica); la palpación prostática no es signo fiable.

Trauma Abdominal

Tarjeta 1 -- FRENTE: Paciente inestable tras trauma cerrado con FAST positivo. ¿Conducta?

REVERSO: Laparotomía exploratoria; las 4 ventanas del FAST: saco pericárdico, espacio de Morrison, fosa esplenorrenal y saco de Douglas (control a los 30 minutos para valorar hemoperitoneo progresivo).

Tarjeta 2 -- FRENTE: Herida penetrante por apuñalamiento. ¿Qué órgano se laceró con mayor frecuencia?

REVERSO: Hígado (40%); el proyectil de arma de fuego involucra más el intestino delgado (50%); en trauma cerrado: bazo (40-50%).

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cuál es la contraindicación absoluta del lavado peritoneal diagnóstico y cuándo se considera positivo?

REVERSO: Indicación existente de laparotomía; positivo con $>100,000$ eritrocitos/ μL , >500 leucocitos/ μL o bacterias en tinción de Gram (sensibilidad 98%); aspiración de sangre fresca en inestable obliga a laparotomía.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Paciente hemodinámicamente estable con trauma cerrado. ¿Cuál es el estudio de elección?

REVERSO: TAC abdominal con contraste (diagnostica lesiones retroperitoneales y pélvicas); FAST y LPD en el paciente inestable; el FAST es no invasivo y repetible.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Líquido libre abdominal sin lesión hepática ni esplénica en la TAC. ¿Qué sugiere y qué conducta?

REVERSO: Lesión del tracto gastrointestinal y/o mesentérico: laparotomía exploratoria temprana.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Evisceración o peritonitis tras trauma abdominal. ¿Conducta?

REVERSO: Laparotomía exploratoria; también indicada con heridas por arma de fuego, hipotensión con herida penetrante, aire libre intraperitoneal o ruptura de hemidiafragma.

Trauma De Columna Y Medula Espinal

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿En qué regiones se distribuyen las lesiones espinales y cuáles son las zonas de transición?

REVERSO: Cervical 55%, torácica 15%, toracolumbar 15% y lumbosacra 15%; zonas de transición: cervical baja y cervico-torácica (C6-T1) y toracolumbar (T11-L2).

Tarjeta 2 -- FRENTE: Paciente con trauma que cursa sin dolor cervical y neurológicamente íntegro. ¿Puede descartarse lesión?

REVERSO: Sí: la ausencia de dolor elimina virtualmente la lesión; con estado de alerta alterado se descarta con estudios radiográficos. La inmovilización prolongada en tabla espinal puede provocar úlceras por presión.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Qué escala clasifica la disfunción neurológica por lesión medular y cómo se define el grado A?

REVERSO: Escala ASIA; grado A (disfunción completa): sin función sensitiva ni motora preservada en los segmentos sacros S4-S5.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Síndrome medular con pérdida de propiocepción y vibratoria, debilidad variable y disfunción vesical. ¿Cuál es?

REVERSO: Síndrome medular posterior; diferenciales: Brown-Séquard (pérdida ipsilateral motora/propioceptiva y contralateral de dolor-temperatura) y del cono medular (anestesia en silla de montar con disfunción vesical y rectal).

Tarjeta 5 -- FRENTE: Paciente con hipotensión persistente y bradicardia tras lesión medular, sin respuesta a líquidos. ¿Diagnóstico y manejo?

REVERSO: Choque neurogénico: vasopresores (fenilefrina, dopamina o noradrenalina) y atropina para la bradicardia; el choque hipovolémico cursa con taquicardia.

Tarjeta 6 -- FRENTE: ¿Qué regla se usa para decidir si solicitar radiografía de columna cervical tras trauma?

REVERSO: Criterios NEXUS: déficit neurológico, intoxicación etílica, lesiones distractores extremas, alteración del estado mental (unable) y sensibilidad espinal (dolor en línea media); siempre con al menos 2 proyecciones más placa con boca abierta para odontoides.

Trauma Maxilofacial

Tarjeta 1 -- FRENTE: Paciente que impactó el rostro contra el tablero sin cinturón, con edema y deformidad facial. ¿Cómo se confirma la fractura del tercio medio facial?

REVERSO: Con TAC (normal o 3D); si no hay equipo, radiografías de maxilar superior, senos paranasales, órbitas o base del cráneo. Diferencial: descartar siempre lesión cervical (inmovilizar) y cerebral asociada.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuál es la principal causa de muerte en el trauma maxilofacial?

REVERSO: Obstrucción de la vía aérea; manejo por ABCDE con énfasis en la vía aérea. Las fracturas cerradas no requieren antibióticos.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Paciente con Le Fort III. ¿Qué complicación es especialmente frecuente?

REVERSO: Lesión intracraneal (presente en 89% de los casos, sobre todo en Le Fort III).

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Qué porcentaje de las fracturas faciales involucra el maxilar?

REVERSO: 30%; predominan en hombres de 20-40 años y suelen ser fracturas cerradas con trazo unilateral (más común).

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Qué lesiones oculares puede provocar el trauma maxilofacial?

REVERSO: Luxación del cristalino, cataratas, desprendimiento de retina o corioideo, hemorragia vítrea, neuropatía óptica traumática y hematoma septal.

Trauma Nasal

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Cuál es la fractura más común del esqueleto craneomaxilofacial y cuál es el mejor estudio de imagen?

REVERSO: Fractura nasal (hombres, 2a-3a décadas; asociada a deportes, caídas y agresiones); mejor estudio: TAC, ya que las radiografías no son útiles.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Trauma nasal con hematoma septal. ¿Conducta?

REVERSO: Incisión y drenaje del hematoma septal; el manejo se realiza en segundo nivel por otorrinolaringología tras estabilización.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Trauma nasal con desviación del puente nasal menor al 50% sin lesión septal. ¿Tratamiento?

REVERSO: Reducción nasal cerrada (RNC); con desviación >50% o <50% con lesión septal: RNC más septoplastia.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Cuándo requiere el trauma nasal reducción abierta?

REVERSO: Fractura conminuta, abierta, nasal bilateral más septal, del complejo naso-órbito-etmoidal (NOE) o cartilaginosa: reducción nasal/septal abierta ± fijación ± injerto.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Qué tipo de trauma nasal es más común y cuál es su pronóstico?

REVERSO: El tipo lateral (más común, menos severo y mejor pronóstico); el frontal se clasifica en 3 planos según profundidad (plano III: disrupción naso-órbito-etmoidal).

Tarjeta 6 -- FRENTE: Fractura nasal con deformidad persistente. ¿Cuándo se difiere la reparación definitiva?

REVERSO: Al menos 6 meses (rinoplastia o reparación de perforación); complicaciones tardías: deformidad, sinusitis, obstrucción, perforación septal y sinequias.

Trauma Ocular

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Qué sistema clasifica el trauma ocular y qué 4 parámetros considera?

REVERSO: Sistema de terminología de Birmingham (incluido en la GPC): tipo de lesión, agudeza visual, pupila (defecto aferente) y zona de la lesión; permite pronóstico de la visión final.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Trauma ocular cerrado por objeto romo. ¿Cómo se llama esa lesión en la clasificación?

REVERSO: Contusión (cerrada); la laceración lamelar es por objeto cortante. En lesiones abiertas: ruptura por objeto romo, penetración (una solución de continuidad) y perforación (dos soluciones de continuidad) por objeto cortante.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cuál es el estudio inicial del trauma ocular en primer nivel y el de elección en el trauma orbitario?

REVERSO: Radiografía simple para descartar cuerpo extraño (estudio inicial y necesario para referir a segundo nivel); TAC de órbita es la mejor elección para el trauma orbitario.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Paciente con malestar intenso, sensación de cuerpo extraño y tinción con fluoresceína positiva tras trauma con uña. ¿Diagnóstico y tratamiento?

REVERSO: Abrasión corneal (impacto tangencial): ungüento antibacteriano y parchado del ojo, cambiando el parche 2-4 veces al día hasta que el ojo esté cómodo.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Trauma contuso con quemosis hemorrágica extensa y ojo blando y colapsado. ¿Diagnóstico y conducta?

REVERSO: Ruptura del globo ocular (baja presión intraocular): exploración quirúrgica urgente. Diferencial: la hemorragia subconjuntival de extensión limitada es común en lesiones contusas y no requiere cirugía.

Tarjeta 6 -- FRENTE: ¿Cuál es el analgésico de elección del trauma ocular?

REVERSO: Ibuprofeno; en contusión retiniana se usa prednisona para reducir cicatrices maculares; en lesiones químicas: lavado con solución fisiológica por al menos 10 minutos.

Trauma Pelvico

Tarjeta 1 -- FRENTE: Paciente con fractura pélvica por compresión lateral. ¿Qué lesión de vías urinarias puede acompañarla?

REVERSO: Rotación interna de la hemipelvis que empuja el pubis hacia las vías urinarias bajas, lesionando vejiga y/o uretra; el ATLS ya no recomienda la palpación prostática para valorar lesiones uretrales.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Fractura en libro abierto de pelvis. ¿Mecanismo y fuente de sangrado?

REVERSO: Compresión anteroposterior (15-20%): rotación externa de la hemipelvis con disrupción de la sínfisis del pubis; hemorragia por desgarro de plexos venosos posteriores y ocasionalmente ramas de la arteria ilíaca interna.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Paciente con choque hemorrágico y pelvis inestable. ¿Cuáles son los 4 sitios potenciales de sangrado?

REVERSO: Superficies óseas fracturadas, plexos venosos pélvicos, lesiones arteriales pélvicas y fuentes extrapélvicas.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Cómo se controla inicialmente el sangrado de la pelvis inestable?

REVERSO: Estabilización con sábana en forma de honda o férulas pélvicas comerciales (rotación interna de los miembros); sangrado pélvico persistente: embolización angiográfica, estabilización o control quirúrgico directo.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Cuál es la mortalidad de la fractura pélvica y su principal factor reversible?

REVERSO: 5-30% global; 10-42% con fractura cerrada más hipotensión; hasta 50% con fractura abierta. Factor principal reversible: hemorragia.

Trauma Pélvico

Tarjeta 1 -- FRENTE: Choque hemorrágico con pelvis inestable. ¿Cuáles son los 4 sitios potenciales de sangrado?

REVERSO: Superficies óseas fracturadas, plexos venosos pélvicos, lesiones arteriales pélvicas y fuentes extrapélvicas.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuál es el mecanismo de fractura pélvica más frecuente y cuál genera hemorragia más severa?

REVERSO: Compresión lateral (60%, colisión automovilística, volumen comprimido, sangrado grave raro); el cizallamiento vertical (5-15%, caída >3.6 m) daña la vasculatura ilíaca y causa hemorragia severa con inestabilidad máxima.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Paciente con fractura de anillo pélvico e hipotensión tras aplastamiento. ¿Manejo inicial del sangrado?

REVERSO: Estabilizar o cerrar la pelvis con sábana en forma de honda o férulas pélvicas (compresión a nivel de los trocánteres); el sangrado pélvico persistente se maneja con embolización angiográfica.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Cuál es el principal factor reversible de mortalidad en la fractura pélvica?

REVERSO: La hemorragia; mortalidad global 5-30%, con hipotensión y fractura cerrada 10-42% y con fractura abierta hasta 50%.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Qué complicaciones puede causar la fijación pélvica prolongada (>24 horas)?

REVERSO: Lesión cutánea y úlceras sobre las prominencias óseas; también se recomienda no palpar la próstata para el abordaje de lesiones uretrales.

Trauma Raquimedular y Síndromes Medulares

Tarjeta 1 -- FRENTE: Paciente con trauma penetrante y pérdida ipsilateral de fuerza, propiocepción y vibratoria, con pérdida contralateral de dolor y temperatura. ¿Diagnóstico?

REVERSO: Síndrome de Brown-Séquard (hemisección medular): el más frecuente tras trauma penetrante. Diferencial: el medular central afecta más las extremidades superiores tras hiperextensión.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Paraplejía con pérdida disociada de dolor y temperatura, conservando propiocepción. ¿Diagnóstico y pronóstico?

REVERSO: Síndrome medular anterior por infarto de la arteria espinal anterior: es la lesión incompleta con peor pronóstico. Diferencial: el medular central tiene buen pronóstico y afecta superiores > inferiores.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cuáles son las zonas de transición con mayor incidencia de lesión raquímedular?

REVERSO: Unión cervical baja y cervico-torácica (C6-T1) y unión toracolumbar (T11-L2); la región cervical es la más susceptible por su movilidad, sobre todo debajo de C3.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Hipotensión con bradicardia tras un trauma con lesión medular que no responde a líquidos. ¿Diagnóstico y manejo?

REVERSO: Choque neurogénico (pérdida de actividad simpática): vasopresores (fenilefrina, dopamina o noradrenalina) y atropina para la bradicardia. Diferencial: el choque hipovolémico cursa con taquicardia.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Está indicado el uso de esteroides en la lesión traumática aguda de la médula espinal?

REVERSO: No hay evidencia que respalde su uso.

Tarjeta 6 -- FRENTE: ¿Qué proyecciones se requieren en la radiografía de columna cervical post-trauma?

REVERSO: 2 proyecciones AP/PA y lateral con boca abierta (odontoides) con tracción caudal de hombros para visualizar las 7 vértebras cervicales; si hay duda, TAC. Indicada ante dolor en línea media, dolor a la palpación, déficit neurológico o sospecha de intoxicación.

Trauma Torácico

Tarjeta 1 -- FRENTE: Paciente con disnea, ingurgitación yugular, hipotensión, desviación traqueal contralateral e hiperresonancia unilateral a la percusión. ¿Diagnóstico y conducta inmediata?

REVERSO: Neumotórax a tensión: descompresión inmediata con aguja en el 5° espacio intercostal, línea axilar media o anterior (catéter 6.5 cm, 14 Fr), sin esperar gabinete; diagnóstico clínico. Diferencial ENARM: taponamiento cardíaco cursa con ruidos respiratorios normales.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuál es el tratamiento definitivo del neumotórax a tensión?

REVERSO: Tubo endopleural de 28-32 Fr en el 5° espacio intercostal, línea axilar media o anterior, por encima del reborde costal.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Tórax succionante por herida grande. ¿Manejo inicial y definitivo?

REVERSO: Gasa estéril fijada en 3 lados (uno descubierto para salida de aire al exhalar), luego sonda endopleural; definitivo: reparación quirúrgica.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Qué define al tórax inestable y qué lesión acompaña regularmente?

REVERSO: Fractura de ≥ 2 costillas consecutivas en ≥ 2 sitios con respiración paradójica; regularmente acompaña contusión pulmonar.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Fractura de primera y segunda costillas. ¿Qué lesión se sospecha?

REVERSO: Lesión de grandes vasos (3a-8a costillas: pulmón, bronquios, corazón y pleura; 9a-12a: hígado, bazo y riñones).

Tarjeta 6 -- FRENTE: Drenaje con gasto >200 mL/hora por 2-4 horas o >1500 mL iniciales. ¿Diagnóstico y conducta?

REVERSO: Hemotórax masivo (generalmente por trauma penetrante): toracotomía de urgencia; el hemotórax simple se drena con sonda 28-32 Fr en el 5° espacio, línea axilar anterior.

Trauma Torácico

Tarjeta 1 -- FRENTE: Paciente con disnea, distensión yugular, hipotensión y desviación traqueal contralateral con ausencia unilateral de murmullo vesicular. ¿Diagnóstico y conducta inmediata?

REVERSO: Neumotórax a tensión: descompresión inmediata con aguja en el 5° espacio intercostal, línea media axilar (catéter 6.5 cm/14 Fr); diagnóstico clínico sin esperar gabinete. Diferencial: taponamiento cardíaco cursa con auscultación pulmonar normal.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuál es el tratamiento definitivo del neumotórax a tensión?

REVERSO: Tubo pleural (sonda endopleural 28-32 Fr) en la misma zona, por encima del reborde costal.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Herida torácica succionante. ¿Manejo inicial y posterior?

REVERSO: Cubierta de gasa estéril fijada en 3 lados (uno descubierto para salida de aire) y luego sonda endopleural; reparación quirúrgica final. Diferencial: neumotórax simple se drena con sonda de 28 Fr en el 4°-5° espacio, línea media axilar.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Cómo se define el tórax inestable y cuál es su mayor riesgo?

REVERSO: Fractura de ≥ 2 costillas consecutivas en ≥ 2 sitios con movimiento paradójico; mayor riesgo: lesión pulmonar asociada (contusión pulmonar).

Tarjeta 5 -- FRENTE: Fractura de 1a y 2a costillas. ¿Qué estructura se sospecha lesionada?

REVERSO: Grandes vasos; 3a-8a costillas: pulmón, bronquios, corazón y pleura; 9a-12a: hígado, bazo y riñones.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Drenaje pleural con gasto mayor de 200 mL/hora durante 2-4 horas o más de 1500 mL inicial. ¿Diagnóstico y conducta?

REVERSO: Hemotórax masivo (generalmente por trauma penetrante): toracotomía de urgencia; el hemotórax simple se drena con sonda 28-32 Fr en el 5° espacio intercostal, línea media axilar.

Trauma de Cuello

Tarjeta 1 -- FRENTE: Herida penetrante de cuello por arma blanca con hematoma pulsátil expansivo y compromiso de la vía aérea. ¿Conducta?

REVERSO: Exploración quirúrgica urgente (signos duros): hemorragia activa, hemoptisis masiva, hematoma expansivo/pulsátil, enfisema subcutáneo masivo, burbujeo por la herida o déficit neurológico.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Herida de cuello con disfagia, ronquera y estridor en paciente hemodinámicamente estable. ¿Manejo?

REVERSO: Signos blandos: TAC de cuello y tórax de la zona lesionada complementada con angiografía, esofagograma y/o broncoscopia; si se demuestra lesión, exploración quirúrgica.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cómo se clasifican las zonas del trauma penetrante de cuello (Monson)?

REVERSO: Zona I: inferior a las clavículas (salida torácica); Zona II: de las clavículas al ángulo de la mandíbula; Zona III: del ángulo mandibular a la base del cráneo.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Herida asintomática por arma blanca en zona III del cuello. ¿Conducta?

REVERSO: Observación sin excepción (6-12 horas); en lesiones vasculares de zona III se realiza angiografía con angioembolización selectiva.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Paciente asintomático con herida por arma de fuego en el cuello. ¿Conducta obligatoria?

REVERSO: TAC para valorar la trayectoria del proyectil y descartar lesiones; en zona II solo se observa a los heridos por arma cortante (los de arma de fuego siguen el manejo de zona I).

Tarjeta 6 -- FRENTE: ¿Qué define una herida penetrante de cuello y qué porcentaje requiere cirugía?

REVERSO: El traspaso del platismo; menos del 15% de estos traumas requieren cirugía.

Traumatismo Craneoencefalico

Tarjeta 1 -- FRENTE: Paciente que tras TCE cursa con periodo de lucidez seguido de deterioro neurológico y TC con imagen biconvexa. ¿Diagnóstico?

REVERSO: Hematoma epidural (0.5% de las lesiones cerebrales; temporal o temporoparietal por laceración de la arteria meníngea media). Diferencial: el subdural (30%) muestra imagen falciforme sin intervalo lúcido.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuál es el objetivo del tratamiento del TCE, cómo se clasifica su gravedad y qué metas de presión arterial se persiguen?

REVERSO: Prevenir la lesión cerebral secundaria (oxigenación y perfusión): Glasgow leve 13-15 (75%), moderado 9-12 (15%), grave <8 (10%). Metas ATLS de PAS: ≥ 110 mmHg (15-49 años y ≥ 70 años) y ≥ 100 mmHg (50-69 años); desplazamiento de línea media ≥ 5 mm indica evacuación quirúrgica.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Qué signos indican fractura de la base del cráneo?

REVERSO: Hemotímpano, ojos de mapache, otorrea y/o rinorrea de LCR y signo de Battle; constituyen criterio de TC en TCE leve.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Cuándo se indica intubación orotraqueal en el TCE pediátrico?

REVERSO: Glasgow <8, caída >3 puntos, coma, anisocoria >1 mm, apnea, pérdida de reflejos laríngeos, $\text{PaCO}_2 > 45$ o $\text{PaO}_2 < 60$ mmHg, hiperventilación con $\text{PaCO}_2 < 25$ mmHg, fracturas inestables del macizo facial, sangrado abundante por boca o convulsiones.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Cuál es la indicación del manitol en el TCE y cuándo no se usan los barbitúricos?

REVERSO: Manitol ante pupila dilatada, hemiparesia o pérdida de conciencia progresiva; los barbitúricos reducen la presión intracraneal refractaria, pero no se usan con hipotensión, hipovolemia ni en reanimación aguda.

Tarjeta 6 -- FRENTE: ¿Qué criterios definen la muerte cerebral y qué estudios la confirman?

REVERSO: Glasgow 3, ausencia de reactividad pupilar y de reflejos de tallo (oculocefálico, oculo vestibular, nauseoso, corneal), apnea formal y sin confusores (alcohol, drogas, hipotermia); EEG de alta ganancia sin actividad, estudios de flujo cerebral o angiografía cerebral.

Traumatismo Craneoencefálico

Tarjeta 1 -- FRENTE: Paciente que tras TCE cursa con lucidez inicial seguida de deterioro neurológico. ¿Diagnóstico?

REVERSO: Hematoma epidural (0.5% de las lesiones intracraneales): región temporal o temporoparietal por laceración de la arteria meníngea media. Diferencial: el subdural (30%) cursa sin intervalo lúcido, por desgarro de vasos corticales superficiales.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Contusión cerebral: ¿qué lóbulos afecta y qué control se indica?

REVERSO: Lóbulos frontal y temporal (20-30% de las lesiones); puede coalescer formando hematoma que requiera evacuación; TAC de control a las 24 horas.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Qué clasifica la gravedad del TCE?

REVERSO: Escala de Coma de Glasgow: leve 13-15, moderado 9-12, severo <8; el 90% de las muertes por trauma se debe a lesión cerebral.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Pupila dilatada, hemiparesia o pérdida de conciencia progresiva en un TCE. ¿Tratamiento?

REVERSO: Manitol; los barbitúricos reducen la presión intracraneal refractaria pero no deben usarse si hay hipotensión, hipovolemia ni en la fase de reanimación aguda.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Cuál es la indicación quirúrgica por desplazamiento de línea media en el TCE?

REVERSO: Desplazamiento ≥ 5 mm contralateral al coágulo; antes del quirófano debe normalizarse la presión arterial y obtenerse TAC de cráneo.

Tarjeta 6 -- FRENTE: ¿Qué fármaco previene las convulsiones en la primera semana tras TCE y qué riesgo las predispone?

REVERSO: Fenitoína (o fosfenitoína) en fase aguda; riesgo de epilepsia tardía si hubo convulsiones tempranas en la primera semana, hematoma intracraneal o fractura craneal deprimida. En comatosos: intubación inmediata y ventilación con O₂ al 100%.

Trombosis Venosa Profunda

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Qué tres componentes integran la tríada de Virchow?

REVERSO: Lesión endotelial, estasis venosa e hipercoagulabilidad.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Postoperatorio de cirugía ortopédica de cadera con edema unilateral, eritema y calor del miembro. ¿Estudio de elección para confirmar TVP?

REVERSO: Ultrasonido Doppler dúplex; ante la sospecha clínica se obtiene dímero-D (Wells + DD negativos excluyen TVP con VPN de 99.5%). Diferencial: la flebografía queda como alternativa en circunstancias especiales.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cómo se interpreta la escala de Wells para TVP?

REVERSO: 0 puntos: probabilidad baja; 1-2: intermedia; ≥ 3 : alta. Suma puntos por cáncer activo, inmovilización, cirugía mayor reciente, sensibilidad en el sistema venoso profundo, edemas y venas colaterales; el diagnóstico alternativo igual de probable resta 2.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Paciente sin cáncer con TVP. ¿Cuál es el tratamiento agudo y la anticoagulación oral de elección?

REVERSO: Heparina de bajo peso molecular (o HNF o fondaparinux) por 5 días, iniciando de forma conjunta AOAD (dabigatrán, rivaroxabán o apixabán) por 3 meses; si no, warfarina con INR 2-3 monitorizado cada 12 semanas.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Paciente con cáncer activo y TVP. ¿Qué anticoagulación se prefiere y por cuánto tiempo?

REVERSO: HBPM durante 3 meses y después AOAD, con anticoagulación indefinida (los AOAD no requieren monitoreo de laboratorio).

Tarjeta 6 -- FRENTE: ¿Qué factores de riesgo se consideran de alto riesgo para TVP?

REVERSO: Cirugía mayor, cáncer activo y enfermedad neurológica con paresia de miembros inferiores.

Tumores Oseos Malignos

Tarjeta 1 -- FRENTE: Adolescente de 16 años con dolor óseo nocturno, no mecánico, en región metafisaria de fémur distal. ¿Diagnóstico más probable?

REVERSO: Osteosarcoma (pico 10-25 años, media 16): tumor maligno más frecuente del hueso (35%); destrucción medular con progresión a cortical y tumoración metafisaria. Diferencial: sarcoma de Ewing afecta la diáfisis con síntomas constitucionales.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuál es el hallazgo radiográfico característico del osteosarcoma?

REVERSO: Imagen en sol naciente o triángulo de Codman (elevación perióstica), piel de cebolla, áreas líticas o escleróticas; radiografía en 2 planos es la técnica óptima de detección.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cuál es el estándar de oro diagnóstico del osteosarcoma y cómo debe planearse?

REVERSO: La biopsia por equipo multidisciplinar con experiencia en sarcomas: el trayecto debe incluirse en el bloque de resección radical (se considera contaminado); RM con gadolinio antes de la biopsia para evaluar extensión local.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Cuál es la quimioterapia neoadyuvante del osteosarcoma y el principal sitio de metástasis?

REVERSO: Doxorubicina-cisplatino, metotrexato a dosis altas con doxorubicina o cisplatino, o ifosfamida-cisplatino; principal sitio de metástasis: parénquima pulmonar (sobrevida metastásica <25% a 12 meses; localizada 60-80% a 5 años).

Tarjeta 5 -- FRENTE: Adolescente con dolor progresivo que cede con reposo, fiebre y masa palpable en diáfisis femoral; imagen en piel de cebolla. ¿Diagnóstico?

REVERSO: Sarcoma de Ewing (segundo tumor óseo más frecuente <20 años, pico 10-15): laminación perióstica en piel de cebolla; biopsia con células redondas azules pequeñas CD99+. Patognomónica: translocación t(11;22)(q24;q12) en 85% de los casos (confirmar con FISH o PCR-TR); la DHL elevada tiene valor pronóstico.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Adulto de 60 años con masa indolora en pelvis con calcificaciones punteadas en áreas radiolúcidas. ¿Diagnóstico?

REVERSO: Condrosarcoma (adultos de edad media o avanzada, raro <40 años): matriz cartilaginosa sin osteoide; signo característico: calcificaciones intralésicas; confirmación con biopsia a cielo abierto.

Úlcera Corneal

Tarjeta 1 -- FRENTE: Usuario de lentes de contacto con infiltrado estromal grisáceo y sucio, edema, hiperemia e hipopión. ¿Diagnóstico?

REVERSO: Absceso (úlceras) corneal bacteriano; factores de riesgo: xeroftalmia, lentes de contacto, diabetes mellitus y edad avanzada. Diferencial: la úlcera herpética muestra imagen dendrítica.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Qué bacterias causan el absceso corneal?

REVERSO: S. aureus, S. pneumoniae, Pseudomonas y Moraxella; se asientan sobre lesiones epiteliales previas (erosiones traumáticas).

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cuál es el tratamiento del absceso corneal bacteriano?

REVERSO: Intrahospitalario con esquema empírico oftálmico: vancomicina + tobramicina hasta obtener el antibiograma; cuadros severos: antibióticos subconjuntivales, midriáticos y analgésicos orales.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Paciente con úlcera corneal de imagen dendrítica que se tiñe con fluoresceína. ¿Etiología y tratamiento?

REVERSO: Herpes simple (95% de las úlceras herpéticas; 5% varicela-zóster): aciclovir tópico, midriáticos y antibióticos. El uso de corticoides está contraindicado.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Cuáles son las complicaciones de la úlcera corneal?

REVERSO: Perforación, cicatriz estromal, sinequias iridocorneales (glaucoma secundario) e iridocristalinas posteriores (cataratas).

Uveitis

Tarjeta 1 -- FRENTE: Paciente con espondilitis anquilosante que acude por ojo rojo, dolor, fotofobia y disminución de la visión. ¿Diagnóstico más probable?

REVERSO: Uveítis anterior aguda (iritis): ~15% de los pacientes con espondilitis anquilosante la desarrolla y suele ser recurrente. Diferencial: la conjuntivitis carece de fotofobia y disminución visual.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Qué enfermedades sistémicas se asocian con uveítis anterior?

REVERSO: Artritis reactiva (casi universal), espondilitis anquilosante (15%), enfermedad inflamatoria intestinal (2-12%) y artritis psoriásica; no la psoriasis aislada.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cuál es el tratamiento de primera línea de la uveítis anterior?

REVERSO: Corticoides tópicos: prednisolona 1%, una gota en el ojo afectado cada 1-6 horas durante la vigilia.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Cuáles son los síntomas de la uveítis?

REVERSO: Inyección conjuntival, disminución de la visión y fotofobia; la inflamación es crónica y la causa rara vez se identifica.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Qué estructuras componen el tracto uveal?

REVERSO: Iris, cuerpo ciliar y coroides; según su compromiso se denomina uveítis anterior o posterior, iritis, iridociclitis o coroiditis.

Vertigo

Tarjeta 1 -- FRENTE: Vértigo rotatorio de menos de 1 minuto desencadenado al girar la cabeza en la cama, con nistagmo con latencia y fatigable en Dix-Hallpike. ¿Diagnóstico?

REVERSO: Vértigo posicional paroxístico benigno (causa más frecuente de vértigo): acumulación de productos de desecho en el canal semicircular posterior; Dix-Hallpike es el estándar de oro diagnóstico.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuál es el tratamiento de primera elección del vértigo posicional paroxístico benigno?

REVERSO: Maniobras de reposicionamiento: maniobra de Epley (primera elección; Semont para canal posterior, Barbecue para canal horizontal, Epley inversa para canal superior), con collarín blando 48 horas posteriores.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Vértigo de horas con tinnitus, hipoacusia neurosensorial y presión auricular. ¿Diagnóstico y tratamiento de elección?

REVERSO: Enfermedad de Menière (exceso de endolinfa, pico 40-50 años): ≥ 2 episodios de vértigo de ≥ 20 minutos con nistagmo horizontal, hipoacusia de ≥ 20 dB en 3 frecuencias y acúfeno o presión; tratamiento inicial de elección: gentamicina intratimpánica (laberintectomía química).

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Qué tratamiento farmacológico se indica en la neuritis vestibular?

REVERSO: Clonazepam 0.25 mg cada 12 horas (hasta 1 mg cada 8 horas); nistagmo horizontal con fase rápida contraria al oído afectado y vértigo constante de días.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Qué vértigo dura minutos y cuál horas según su causa?

REVERSO: Minutos: ataque isquémico transitorio (2-5 min, súbito); horas: migraña y enfermedad de Menière; días: neuronitis vestibular y accidente cerebrovascular; <1 min: vértigo posicional con movimientos de la cabeza.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Paciente con vértigo, ataxia y disartria. ¿A dónde se refiere?

REVERSO: Neurología (síntomatología neurológica sugiere vértigo central); en vértigo posicional paroxístico benigno el envío es a otorrinolaringología para maniobras de reposicionamiento.

Xeroftalmia

Tarjeta 1 -- FRENTE: Mujer de 50 años con ardor, picor y visión borrosa transitoria al despertar que mejora al parpadear, en contexto de síndrome de Sjögren. ¿Diagnóstico?

REVERSO: Xeroftalmía (ojo seco): reducción del componente acuoso con aumento compensador de moco que nubla la visión; se acentúa por la menor producción lagrimal nocturna. Asociada a artritis reumatoide, Sjögren, Stevens-Johnson y penfigoide cicatricial ocular.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Qué medicamentos causan ojo seco?

REVERSO: Betabloqueadores, inhibidores de la anhidrasa carbónica, antihistamínicos, vasoconstrictores, corticoesteroides, antiglaucomatosos, isotretinoína, atropina y diuréticos; también cirugía refractiva (LASIK).

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Qué pruebas se usan para el diagnóstico de la xeroftalmía y cuál es el tiempo de ruptura lagrimal normal?

REVERSO: Biomicroscopía, tiempo de ruptura lagrimal (normal >10 segundos), Schirmer I y II y tinción con rosa de Bengala, fluoresceína o verde de lisamina; el diagnóstico es fundamentalmente clínico.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Qué lágrimas artificiales se aplican durante el día y cuáles antes de dormir?

REVERSO: Día: viscosidad baja (polietilenglicol), no nublan la visión; noche: viscosidad alta (carboximetilcelulosa), duración prolongada pero nublan la visión.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Qué opciones existen cuando las lágrimas artificiales no controlan el ojo seco?

REVERSO: Oclusión del conducto nasolagrimal con tapones sintéticos o procedimientos quirúrgicos permanentes; ciclosporina oftálmica preserva el tejido glandular inflamado.